CareJiyo

Sổ tay người sử dụng

Quy trình nghiệp vụ, màn hình và công việc hằng ngày

TIẾNG VIỆT

Điểm bắt đầu thực tế cho nhân viên mới. Hiểu toàn bộ hành trình, sau đó dùng hướng dẫn công việc và video để thực hành.

Ngày 8 tháng 11 năm 2026

carejiox.com

CareJiyo Learning

Mục lục

Chọn tiêu đề để đến phần tương ứng. Dấu trang PDF cũng hỗ trợ điều hướng.

Bắt đầu: cách phòng khám làm việc 5

1.1 CareJiyo giúp bạn làm gì . . . 6

1.2 Đăng nhập và hiểu quyền sử dụng . . . 7

1.3 Danh sách, biểu mẫu, nút và thay đổi đã lưu . . . 8

1.4 Biết khi nào công việc đã hoàn tất . . . 9

CRM: tiếp nhận yêu cầu và theo dõi 10

2.1 Đọc bảng tổng quan CRM . . . 11

2.2 Ghi liên hệ và tránh tạo trùng . . . 12

2.3 Hoạt động, chuyển xử lý và bàn giao đặt lịch . . . 13

2.4 Care Command, hộp thư kênh và điện thoại . . . 14

2.5 Mối quan hệ, yêu cầu từ web và quảng cáo . . . 15

Khách hàng, lịch hẹn và báo giá 16

3.1 Hồ sơ khách hàng và người đại diện . . . 17

3.2 Tạo một buổi khám hoặc nhiều ngày . . . 18

3.3 Đọc màn hình và vòng đời lịch hẹn . . . 19

3.4 Hiểu báo giá và dịch vụ bổ sung . . . 20

3.5 Đổi lịch, hủy và tránh công việc trùng . . . 21

Điều phối: nhân sự và ngày làm việc 22

4.1 Dùng bảng tổng quan Điều phối . . . 23

4.2 Lịch nhân viên, Nghỉ phép, Khối lượng và Tuyến đường . . . 24

4.3 Ngoại lệ, bàn giao tiền và phát triển nhân viên . . . 25

Ứng dụng di động cho điều dưỡng và bác sĩ 26

5.1 Mở ứng dụng và tìm lịch được giao . . . 27

5.2 Thực hiện buổi khám từng bước . . . 28

5.3 Ghi chú, nhập giọng nói, ký và xác minh . . . 29

5.4 Khách hàng, cuộc gọi, tin gia đình và hồ sơ cá nhân . . . 30

Hồ sơ lâm sàng và phối hợp chăm sóc 31

6.1 Dấu hiệu sinh tồn và quan sát . . . 32

6.2 Thông tin chăm sóc: danh sách ưu tiên, cảnh báo và NEWS2 . . . 33

6.3 Kế hoạch chăm sóc và nhiệm vụ buổi khám . . . 34

6.4 Y lệnh thuốc và sổ thực hiện thuốc . . . 35

6.5 Đánh giá và biểu mẫu lâm sàng . . . 36

6.6 Ghi chú, chẩn đoán và duyệt mã . . . 37

6.7 Sự đồng ý và quyền chia sẻ . . . 38

6.8 Báo cáo sự cố và theo dõi khắc phục . . . 39

Khám từ xa và liên lạc gia đình 40

7.1 Khám từ xa và tự đặt lịch . . . 41

7.2 Hộp thư gia đình, liên kết buổi khám và My Care . . . 42

Tài chính: hóa đơn, thanh toán và số dư 43

8.1 Đọc Tài chính và trạng thái hóa đơn . . . 44

8.2 Kiểm tra và lập đúng hóa đơn . . . 45

8.3 Nhận thanh toán toàn bộ hoặc một phần . . . 46

8.4 Tiền mặt hiện trường, nhận tại văn phòng và đối chiếu . . . 47

8.5 Công nợ, hoàn tiền, ghi có và gói dịch vụ . . . 48

8.6 Nhật ký VAT, hóa đơn điện tử và hồ sơ BHYT . . . 49

Báo cáo, học tập và xử lý vấn đề hằng ngày **50**

9.1 Phân tích và báo cáo hữu ích 51

9.2 Học qua hướng dẫn, video và trợ lý 52

9.3 Lộ trình đào tạo và thực hành 53

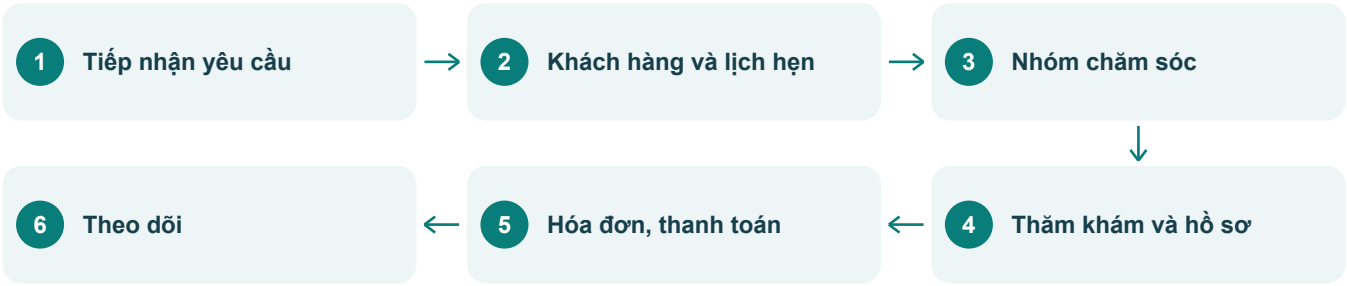
9.4 Khi có việc không hoạt động 54

9.5 Từ điển dễ hiểu và danh sách kiểm tra mỗi ngày 55

CHƯƠNG 01

Bắt đầu: cách phòng khám làm việc

Quy trình thông thường



Trong chương này

CareJiyo giúp bạn làm gì

Đăng nhập và hiểu quyền sử dụng

Danh sách, biểu mẫu, nút và thay đổi đã lưu

Biết khi nào công việc đã hoàn tất

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

1.1 CareJiyo giúp bạn làm gì

CareJiyo kết nối bộ phận văn phòng với nhóm chăm sóc tại nhà. CRM tiếp nhận yêu cầu. Điều phối sắp xếp lịch hẹn và nhân viên. Lâm sàng lưu thông tin chăm sóc. Tài chính theo dõi hóa đơn và tiền đã nhận. Ứng dụng di động giúp điều dưỡng hoặc bác sĩ được phân công làm việc tại buổi khám. Mục Học tập cung cấp hướng dẫn và video.

Liên hệ là người đã gửi yêu cầu. Khách hàng là người được chăm sóc. Lịch hẹn là một buổi khám. Phân công gắn nhân viên với lịch hẹn đó. Ghi chú lâm sàng ghi lại việc chăm sóc. Hóa đơn ghi số tiền phải trả; khoản thanh toán ghi số tiền đã nhận. Đây là các hồ sơ liên kết với nhau, không phải các tên gọi khác nhau của cùng một hồ sơ.

Ví dụ: người con gái gọi đặt dịch vụ cho cha. Ghi người con là người gọi hoặc người đại diện và người cha là khách hàng được chăm sóc. Tạo lịch hẹn cho người cha, phân công nhóm chăm sóc, ghi nhận buổi khám và kiểm tra hóa đơn. Phân biệt rõ mối quan hệ để liên lạc đúng người và chăm sóc đúng người.

Đọc chương 1-2 trước. Nhân viên văn phòng đọc tiếp phần lịch hẹn và điều phối; nhân viên y tế đọc phần di động và hồ sơ lâm sàng; kế toán đọc phần thanh toán. Xem video hướng dẫn công việc khi bạn sẵn sàng thực hành.

1.2 Đăng nhập và hiểu quyền sử dụng

1. Mở https://carejiox.com bằng Chrome. Dùng tài khoản và mật khẩu cá nhân được cấp. Sản phẩm có tên CareJiyo; địa chỉ hiện tại vẫn là carejiox.com.

2. Kiểm tra tên của bạn, ngôn ngữ và phòng khám. Nếu có bộ chọn ngôn ngữ, chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Kiểm tra ngày giờ lịch hẹn theo múi giờ của phòng khám.

3. Dùng Trang chủ (Home) để trở về màn hình bắt đầu. Chọn khu vực như CRM, Điều phối, Lâm sàng, Tài chính hoặc Học tập. Các thẻ bên trong mở những màn hình tương ứng.

4. Kiểm tra bộ lọc Khu vực phụ trách (Catchment Area) trước khi tìm kiếm. Đây là địa bàn phòng khám phục vụ. Quản lý điều phối chỉ được truy cập khu vực được giao; đổi bộ lọc không tạo thêm quyền. Điều dưỡng và bác sĩ cũng làm việc trong phạm vi và lịch được phân công.

5. Nếu không thấy trình đơn hoặc hồ sơ, kiểm tra ngày, bộ lọc, khu vực và phân công. Nhờ quản lý kiểm tra quyền nếu vẫn không tìm thấy. Không dùng tài khoản của đồng nghiệp.

Một số màn hình hiển thị tên hoặc logo riêng của phòng khám. Bố cục có thể khác đôi chút theo vai trò, ngôn ngữ và tính năng đã bật. Ảnh minh họa giúp nhận biết các điều khiển; hãy dựa vào thông tin và trạng thái trong phiên làm việc của bạn.

1.3 Danh sách, biểu mẫu, nút và thay đổi đã lưu

Danh sách hiển thị nhiều hồ sơ; biểu mẫu hiển thị một hồ sơ. Ô tìm kiếm thu hẹp danh sách. Bộ lọc chọn một nhóm, chẳng hạn lịch hẹn hôm nay. Nhóm theo (Group By) sắp hồ sơ dưới các tiêu đề. Bỏ bộ lọc chỉ hiển thị thêm hồ sơ trong phạm vi quyền, không làm thay đổi dữ liệu.

Điều khiển	Ý nghĩa
Mới / Tạo (New / Create)	Mở hồ sơ trống. Tìm hồ sơ hiện có trước.
Lưu / Lưu thủ công	Lưu thay đổi đã nhập. Đọc thông báo kiểm tra dữ liệu.
Bỏ thay đổi (Discard all changes)	Bỏ phần chưa lưu; không hoàn tác thay đổi đã lưu trước đó.
Tìm kiếm / Bộ lọc	Tìm theo mã, người, ngày hoặc trạng thái.
Danh sách / Lịch / Biểu đồ / Bảng tổng hợp	Các cách xem cùng dữ liệu trong phạm vi quyền.
Ghi chú nội bộ (Log note)	Thêm nhận xét vào lịch sử hồ sơ.
Gửi tin nhắn (Send message)	Gửi cho người nhận được chọn; kiểm tra người nhận trước.
Hoạt động (Activities)	Giao việc theo dõi và đặt hạn xử lý.
Làm mới (Refresh)	Tải lại thông tin đang hiển thị.

Dấu sao hoặc trường được tô nổi có thể chỉ thông tin bắt buộc. Đọc nhãn và hướng dẫn của trường. Chọn đúng giá trị trong danh sách; hai khách hàng trùng tên chưa chắc là một người. Trước khi lưu, kiểm tra khách hàng, mã hồ sơ, ngày và số tiền. Mở lại hồ sơ quan trọng để xác nhận đã lưu.

1.4 Biết khi nào công việc đã hoàn tất

Mỗi bộ phận bàn giao một kết quả rõ ràng cho bộ phận tiếp theo. CRM bàn giao đúng khách hàng và yêu cầu. Điều phối bàn giao lịch hẹn đã thống nhất, dịch vụ và nhân viên đã nhận phân công. Nhân viên y tế bàn giao buổi khám hoàn tất và hồ sơ chăm sóc chính xác. Kế toán kiểm tra hóa đơn, ghi nhận tiền thực nhận và theo dõi số dư.

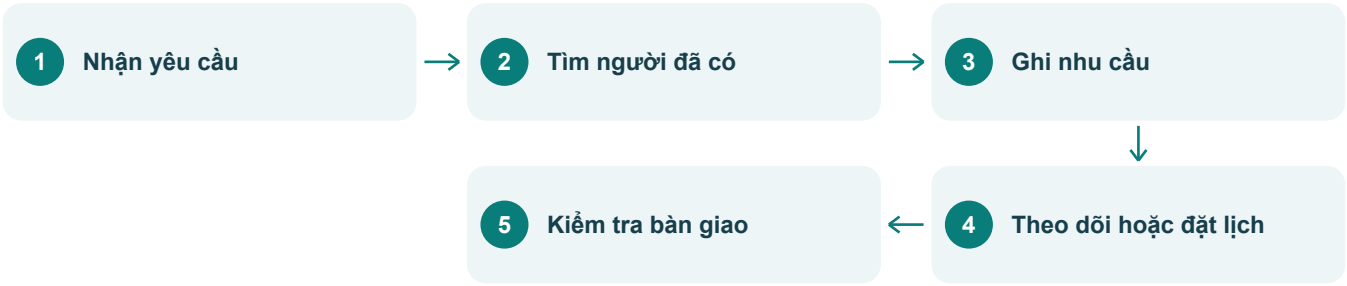
Lịch hẹn ở trạng thái Hoàn tất không tự chứng minh hóa đơn đã thanh toán. Khoản tiền được ghi là đã thu chưa chắc đã được bàn giao về văn phòng. Ghi chú đã lưu chưa chắc là ghi chú cuối cùng đã ký. Luôn kiểm tra trạng thái riêng của công việc bạn phụ trách.

Cuối ca, xem lại hoạt động chưa xong, lịch chưa có nhân viên, ghi chú chưa hoàn tất và tiền chờ bàn giao. Ghi rõ bước tiếp theo và người chịu trách nhiệm. Nếu thao tác lỗi, ghi mã hồ sơ cùng thông báo chính xác rồi liên hệ người phụ trách. Tránh bấm lặp lại nút tạo lịch hẹn, hóa đơn hoặc thanh toán.

CHƯƠNG 02

CRM: tiếp nhận yêu cầu và theo dõi

Quy trình thông thường



Trong chương này

Đọc bảng tổng quan CRM

Ghi liên hệ và tránh tạo trùng

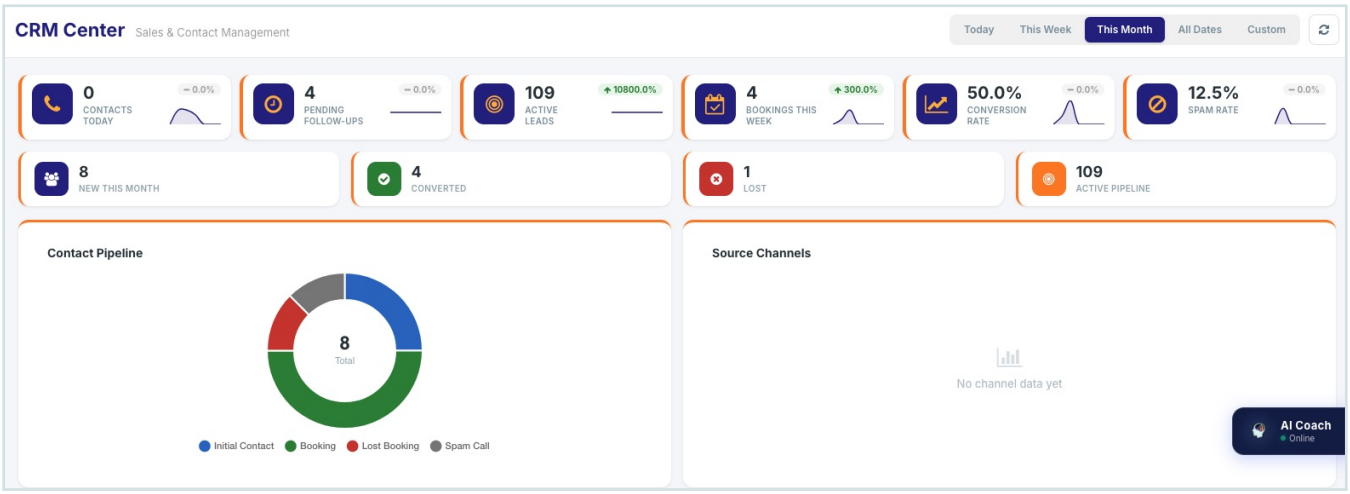
Hoạt động, chuyển xử lý và bàn giao đặt lịch

Care Command, hộp thư kênh và điện thoại

Mối quan hệ, yêu cầu từ web và quảng cáo

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

2.1 Đọc bảng tổng quan CRM



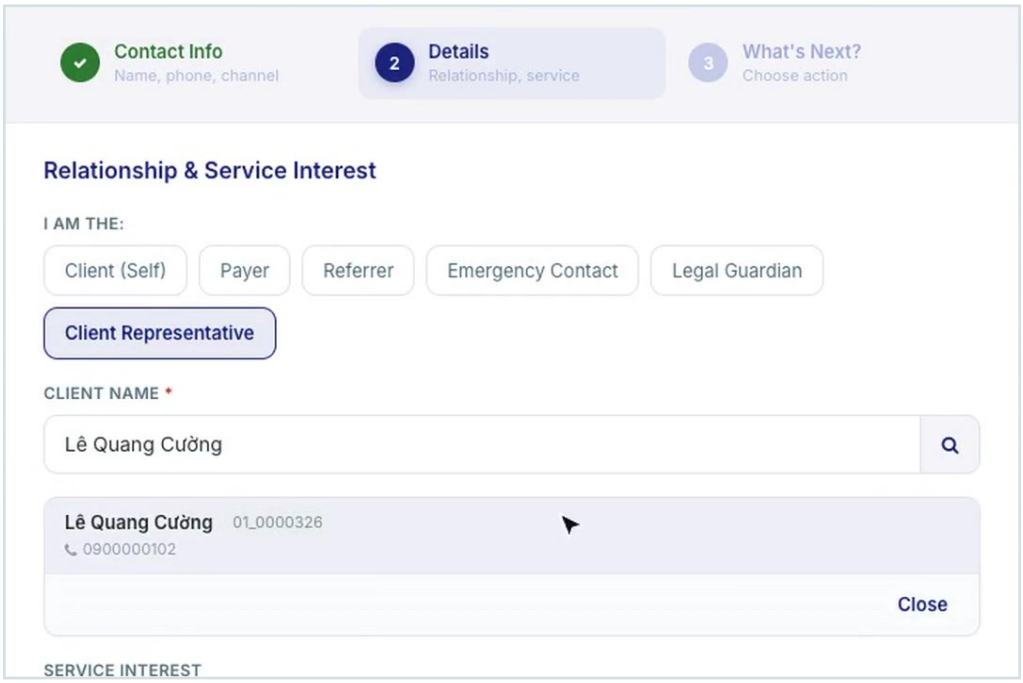
Hình 1. Bảng CRM: chọn kỳ, ô tổng hợp và quy trình.

Mở CRM > Bảng tổng quan khi bắt đầu ca. Chọn khoảng thời gian và khu vực trước. Các ô thống kê tóm tắt liên hệ, việc theo dõi, khách hàng tiềm năng, lịch hẹn và tỷ lệ chuyển đổi. Biểu đồ quy trình nhóm liên hệ theo giai đoạn; thông tin nguồn cho biết yêu cầu đến từ đâu. Liên hệ gần đây và Lịch hẹn sắp tới giúp mở nhanh hồ sơ.

1. Chọn Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tất cả ngày hoặc khoảng tùy chọn.
2. Đọc nhãn từng ô. Một số ô ghi rõ khoảng thời gian riêng; không mặc định mọi số liệu dùng cùng cách xác định ngày.
3. Mở ô thống kê hoặc chức năng xem chi tiết để xem hồ sơ tạo nên số liệu. Kiểm tra ngày và trạng thái trước khi kết luận.
4. Làm mới sau thay đổi và xem danh sách cần theo dõi.

Dùng bảng tổng quan để biết việc cần chú ý, rồi xử lý trên liên hệ hoặc lịch hẹn. Số lượng cao là dấu hiệu cần xem xét, không có nghĩa mọi yêu cầu cần cùng một cách xử lý.

2.2 Ghi liên hệ và tránh tạo trùng



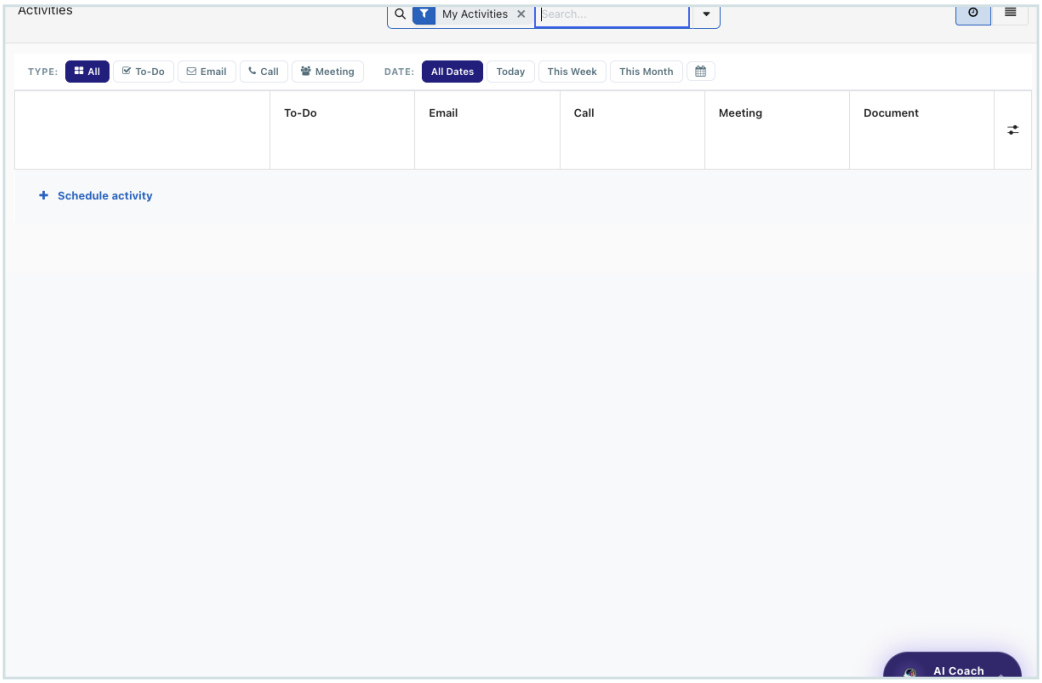
Hình 2. Trình liên hệ: chọn quan hệ và đúng khách hàng.

Mở CRM > Liên hệ > Tất cả liên hệ. Tìm số điện thoại và tên trước khi tạo mới. Người gọi lại có thể đã có hồ sơ khách hàng và lịch hẹn cũ.

1. Chọn Mới nếu chưa có liên hệ phù hợp. Nhập thông tin người gọi và nguồn yêu cầu.
2. Xác định người cần dịch vụ. Nếu người gọi đại diện cho người khác, ghi riêng mối quan hệ và thông tin khách hàng.
3. Ghi dịch vụ yêu cầu, địa điểm, mức khẩn và ghi chú cần thiết cho bộ phận tiếp nhận. Dùng giá trị được duyệt trong danh sách chọn.
4. Lưu rồi mở lại liên hệ. Kiểm tra số điện thoại, khu vực và bước tiếp theo.
5. Nếu chưa thống nhất lịch hẹn, dùng Ghi nhận khách hàng tiềm năng (Log as Lead) hoặc chức năng theo dõi phù hợp. Có thể lưu liên hệ mà chưa tạo lịch hẹn.

Chỉ đánh dấu Rác (Spam) khi đúng là yêu cầu không hợp lệ. Không dùng Spam để che một yêu cầu thật nhưng khó xử lý. Nếu mất cơ hội đặt lịch, dùng Booking Lost khi có và ghi lý do. Lịch sử liên hệ cần thể hiện rõ diễn biến.

2.3 Hoạt động, chuyển xử lý và bàn giao đặt lịch



Hình 3. Hoạt động: tìm loại việc, người phụ trách và hạn.

Thao tác	Khi nào dùng
Ghi hoạt động / Lên lịch hoạt động	Cần gọi, nhắn tin, họp hoặc theo dõi khác.
Ghi nhận khách hàng tiềm năng	Giữ yêu cầu thật để tiếp tục theo dõi.
Chuyển xử lý (Escalate)	Cần quản lý, điều dưỡng trưởng hoặc bác sĩ xử lý.
Đặt lịch (Book)	Khách hàng sẵn sàng đặt hẹn; mở trình tạo lịch.
Mất cơ hội đặt lịch (Booking Lost)	Không tiếp tục đặt lịch; ghi rõ lý do.

1. Mở liên hệ và chọn Ghi hoạt động. Chọn loại hoạt động, người phụ trách, hạn và nội dung rõ ràng.
2. Tìm việc tại CRM > Hoạt động. Lọc theo loại hoặc ngày, thực hiện theo dõi, ghi kết quả rồi hoàn tất hoạt động. Tạo hoạt động mới nếu cần theo dõi tiếp.
3. Khi chuyển xử lý, chọn đúng vai trò tiếp nhận và giải thích câu hỏi. Kiểm tra yêu cầu đến đúng người.
4. Khi đặt lịch, xác nhận khách hàng đã có trước khi tạo khách hàng mới. Nhập chi tiết buổi khám và kiểm tra lịch vừa tạo. Mã lịch hẹn là thông tin bàn giao cho Điều phối.

Nếu vai trò của bạn không được tạo lịch, chuyển liên hệ cho nhóm đặt lịch có quyền. Hoàn tất một hoạt động chỉ đóng việc theo dõi đó, không tự có nghĩa toàn bộ yêu cầu đã được giải quyết.

2.4 Care Command, hộp thư kênh và điện thoại

Care Command tập hợp các hội thoại hiện có thành hàng đợi xử lý. Dùng bộ lọc để tìm hội thoại, mở chuỗi tin, đọc lịch sử và xác định đúng người trước khi trả lời hoặc giao người phụ trách. Liên hệ hay lịch hẹn được gắn cung cấp bối cảnh; trùng tên chưa đủ để xác nhận danh tính.

Trung tâm kênh hiển thị các kênh đã kết nối. Liên hệ chưa định tuyến chứa mục còn cần xác định phòng khám, người hoặc tuyến xử lý. Tin nhắn kênh và Nhật ký kênh giúp nhân viên có quyền kiểm tra việc gửi và định tuyến. Khả năng sử dụng phụ thuộc kết nối của phòng khám. Hộp thư trống không chứng minh mọi tài khoản bên ngoài đã kết nối.

Điện thoại > Cuộc gọi hiển thị hoạt động gọi; Gọi lại hỗ trợ công việc gọi lại; Bản ghi âm mở bản ghi hiện có; Hồ sơ từ hệ thống điện thoại hiển thị lịch sử nhà cung cấp. Kiểm tra số và quyền trước khi gọi hoặc mở bản ghi. Ghi kết quả vào liên hệ phù hợp.

Nếu có bản nháp AI hoặc mẫu trả lời, đọc, sửa rồi chủ động gửi. Kiểm tra người nhận và kênh trước khi Gửi. Không xem gợi ý là tư vấn lâm sàng đã được xác nhận. Chuyển lỗi gửi cho quản trị kênh; tránh gửi trùng khi tin đầu vẫn đang chờ.

2.5 Mối quan hệ, yêu cầu từ web và quảng cáo

Mối quan hệ ghi cách các cá nhân liên quan với nhau, chẳng hạn khách hàng và người đại diện gia đình. Xác nhận đúng hai người và loại quan hệ trước khi lưu. Hồ sơ quan hệ không tự cấp quyền xem thông tin sức khỏe.

Web & Quảng cáo > Điểm tiếp xúc web ghi thông tin nguồn truy cập hiện có, như nguồn và chiến dịch. Phân tích khách hàng tiềm năng tổng hợp luồng yêu cầu. Google Ads hiển thị thông tin từ tài khoản đã kết nối. Các màn hình này giúp biết nguồn nào mang lại yêu cầu, không thay thế nhu cầu dịch vụ thực tế trong liên hệ.

1. Chọn ngày và khu vực phù hợp nếu có bộ lọc.
2. Mở yêu cầu liên kết để xem việc xử lý sau khi tiếp nhận.
3. So sánh nhãn nguồn một cách nhất quán. Thiếu thông tin nguồn có thể do nguồn chưa được cung cấp.
4. Báo vấn đề kết nối hoặc thiếu dữ liệu cho quản trị viên. Không tạo liên hệ trùng để làm thay đổi số liệu biểu đồ.

Chỉ dùng kênh trực tiếp khi phòng khám đã bật. Khi phù hợp, tiếp tục ghi yêu cầu đến trực tiếp hoặc nhận thủ công bằng biểu mẫu liên hệ.

CHƯƠNG 03

Khách hàng, lịch hẹn và báo giá

Quy trình thông thường



Trong chương này

Hồ sơ khách hàng và người đại diện

Tạo một buổi khám hoặc nhiều ngày

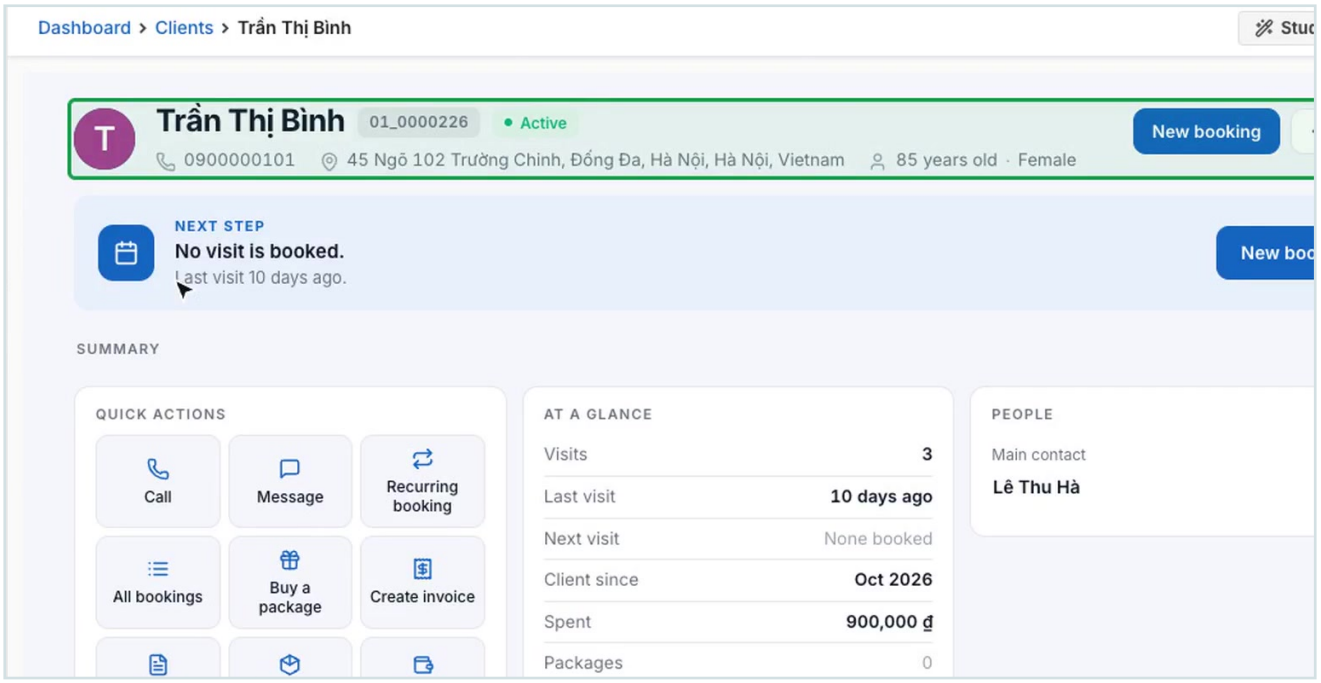
Đọc màn hình và vòng đời lịch hẹn

Hiểu báo giá và dịch vụ bổ sung

Đổi lịch, hủy và tránh công việc trùng

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

3.1 Hồ sơ khách hàng và người đại diện



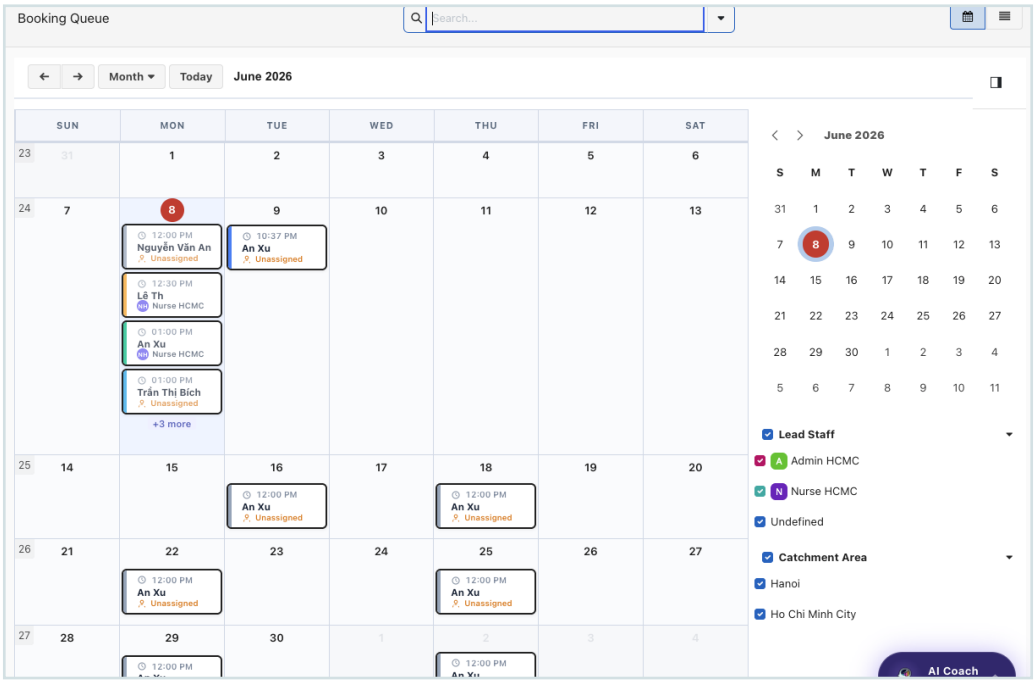
Hình 4. Hồ sơ khách hàng: kiểm tra danh tính và liên hệ trước thao tác.

Mở Điều phối > Khách hàng và tìm trước khi tạo hồ sơ. Hồ sơ liên kết thông tin nhận diện, liên lạc, địa chỉ, lịch hẹn, gói dịch vụ và thông tin lâm sàng trong phạm vi quyền. Một khách hàng có thể có nhiều lần khám và nhiều người đại diện.

1. Xác nhận tên, điện thoại và một thông tin nhận diện phù hợp khác. Không chọn chỉ vì trùng tên.
2. Kiểm tra địa chỉ cung cấp dịch vụ, quận/huyện, khu vực và cơ sở. Xem vị trí bản đồ và khoảng cách nếu có. Địa chỉ thiếu có thể làm sai vị trí; xác nhận điểm đến thực tế.
3. Kiểm tra người đại diện và mối quan hệ. Phân biệt người được chăm sóc với người đặt lịch hoặc thanh toán.
4. Dùng lối tắt lịch hẹn hoặc hóa đơn để xem lịch sử trước khi tạo việc mới.
5. Cập nhật thông tin trong phạm vi quyền và lưu. Mở lại để kiểm tra sửa đổi quan trọng.

Các thẻ lâm sàng, kế hoạch chăm sóc, chẩn đoán, đồng ý và quyền gia đình xuất hiện theo vai trò và tính năng. Chỉ đọc thông tin cần cho công việc. Tổng số trên hồ sơ là bản tóm tắt; mở lịch hẹn hoặc hóa đơn gốc để kiểm tra một khoản cụ thể.

3.2 Tạo một buổi khám hoặc nhiều ngày



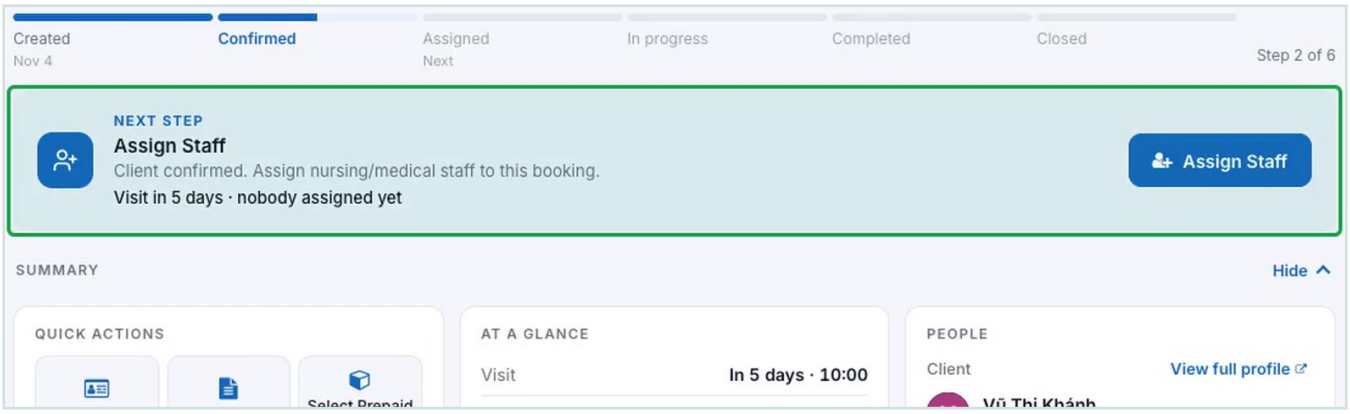
Hình 5. Lịch: chọn kỳ và mở lịch hẹn để xem chi tiết.

Một lịch hẹn cần khách hàng, dịch vụ, địa điểm, giờ dự kiến và thời lượng. Tạo từ hồ sơ khách hàng, trình đặt lịch của liên hệ hoặc Điều phối > Lịch hẹn theo quyền của bạn.

1. Tìm đúng khách hàng. Xác nhận dịch vụ tại nhà, tại phòng khám hay trực tuyến.
2. Chọn cơ sở, khu vực, loại dịch vụ và địa chỉ chính xác. Nhập ngày, giờ và thời lượng dự kiến.
3. Thêm dịch vụ, số lượng và chi tiết đã thống nhất. Với lịch lặp lại hoặc nhiều ngày, kiểm tra từng ngày để tránh trùng hoặc chồng lịch.
4. Lưu và kiểm tra mã lịch hẹn. Mở báo giá, kiểm tra phí trước khi xác nhận hẹn.
5. Xác nhận khi các chi tiết đã thống nhất. Sau đó phân công nhân viên và kiểm tra việc nhận lịch.

Dùng dạng danh sách để tìm theo mã hoặc trạng thái; dùng lịch để xem thời gian. Khi tìm ngày khám, dùng trường ngày dự kiến thay vì mặc định ngày tạo hồ sơ là ngày khám. Sau khi tạo nhiều ngày, đếm số lịch hẹn và kiểm tra ngày đầu, ngày cuối.

3.3 Đọc màn hình và vòng đời lịch hẹn



Hình 6. Lịch hẹn: kiểm tra trạng thái, dịch vụ và bước tiếp theo.

Màn hình lịch hẹn tập hợp khách hàng, dịch vụ, giờ dự kiến, nhân viên, công việc lâm sàng và liên kết tài chính. Trạng thái cho biết giai đoạn đã đạt. Khung Hành động tiếp theo đề xuất thao tác phù hợp trạng thái; kiểm tra chi tiết trước khi dùng.

Giai đoạn hoặc nút	Ý nghĩa
Nháp / Đã tạo	Đang chuẩn bị thông tin.
Xác nhận lịch hẹn (Confirm Booking)	Xác nhận chi tiết đã thống nhất.
Đã phân công	Đã gắn nhân viên; cần kiểm tra họ đã nhận lịch chưa.
Bắt đầu dịch vụ / Đang thực hiện	Dịch vụ thực tế đã bắt đầu và được ghi thời gian.
Hoàn tất dịch vụ / Hoàn tất	Đã xong phần dịch vụ; kiểm tra riêng ghi chú, câu hỏi kết thúc và hóa đơn.
Hoàn tất - Chờ hóa đơn	Đã xong dịch vụ nhưng còn việc lập hóa đơn.
Xem báo giá / Thanh toán / Phân công	Mở hồ sơ liên quan.
Đóng (Close)	Kết thúc lịch hẹn khi công việc bắt buộc đã hoàn thành.

Hệ thống có thể tạo hoặc liên kết hóa đơn khi hoàn tất, tùy quy trình. Mở hóa đơn liên kết trước khi dùng Tạo hóa đơn để tránh trùng. Nhân viên hỗ trợ hoàn tất phần được giao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa người phụ trách chính đã hoàn tất cả buổi khám.

3.4 Hiểu báo giá và dịch vụ bổ sung

Báo giá giải thích phí dự kiến. Số tiền có thể phụ thuộc dịch vụ, số lượng, nhóm nhân viên hoặc dịch vụ, khu vực, ngày, giờ, thời lượng, đi lại và chiết khấu được duyệt. Hóa đơn là chứng từ tính phí theo giá trị cuối cùng.

1. Mở Xem báo giá từ lịch hẹn. Kiểm tra khách hàng, tiền tệ và từng dòng dịch vụ.
2. Đối chiếu số lượng, đơn giá, thời gian thêm, phí đi lại và chiết khấu với dịch vụ đã thống nhất. Xem bảng phân tích, không chỉ tổng tiền.
3. Nếu bổ sung dịch vụ tại buổi khám, dùng Thêm dịch vụ (Add Service) hoặc thao tác dòng dịch vụ hiện có. Chọn đúng dịch vụ và số lượng; không ghi thay bằng chiết khấu hoặc thanh toán thủ công.
4. Lưu hoặc tính lại bằng nút có trên báo giá. Kiểm tra số tiền cập nhật và các dòng hóa đơn phát sinh.
5. Báo đồng nghiệp văn phòng phụ trách nếu đã có hóa đơn và cần điều chỉnh.

Không mặc định giá trong ví dụ là giá hiện tại của phòng khám. Cần kiểm tra biểu phí thiếu, khu vực sai hoặc giờ khám sai trước khi lập hóa đơn. Nhờ quản trị giá có quyền sửa cấu hình; người dùng thông thường không nên đổi bảng giá gốc chỉ để sửa một báo giá.

3.5 Đổi lịch, hủy và tránh công việc trùng

Để đổi lịch, mở lịch hẹn hiện có và chọn Đổi lịch (Reschedule). Kiểm tra giờ mới, thời lượng và nhân viên phù hợp. Nếu đổi điều dưỡng, xác nhận cả phân công cũ và mới. Mở lại lịch hẹn, xem trên lịch sau khi lưu. Khi có tính năng kéo trên lịch nhân viên, di chuyển khối là đổi lịch thật, không chỉ đổi cách hiển thị; đọc xác nhận và cảnh báo.

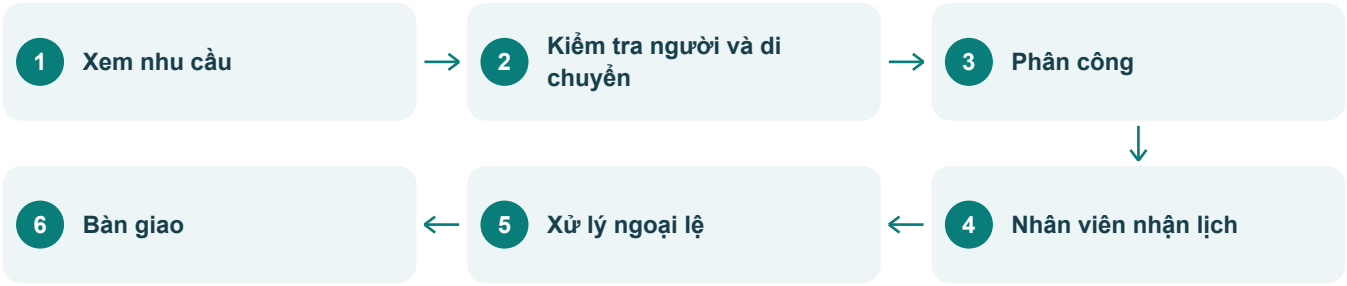
Để hủy, dùng Hủy lịch hẹn và ghi lý do thực tế. Kiểm tra kết quả phân công và thông báo phù hợp việc hủy. Không xóa khách hàng chỉ vì một buổi khám bị hủy. Với công việc đã hoàn tất hoặc đã lập hóa đơn, nhờ Điều phối và Tài chính xử lý điều chỉnh thích hợp thay vì che lịch sử.

Nếu trình duyệt báo lỗi hoặc hết thời gian chờ, tìm mã lịch hẹn trước khi tạo lại. Nếu đổi lịch thành công nhưng tin nhắn thất bại, xử lý phần thông báo riêng. Lịch hẹn, phân công, hóa đơn và tin nhắn gửi đi đều có hồ sơ diễn biến riêng.

CHƯƠNG 04

Điều phối: nhân sự và ngày làm việc

Quy trình thông thường



Trong chương này

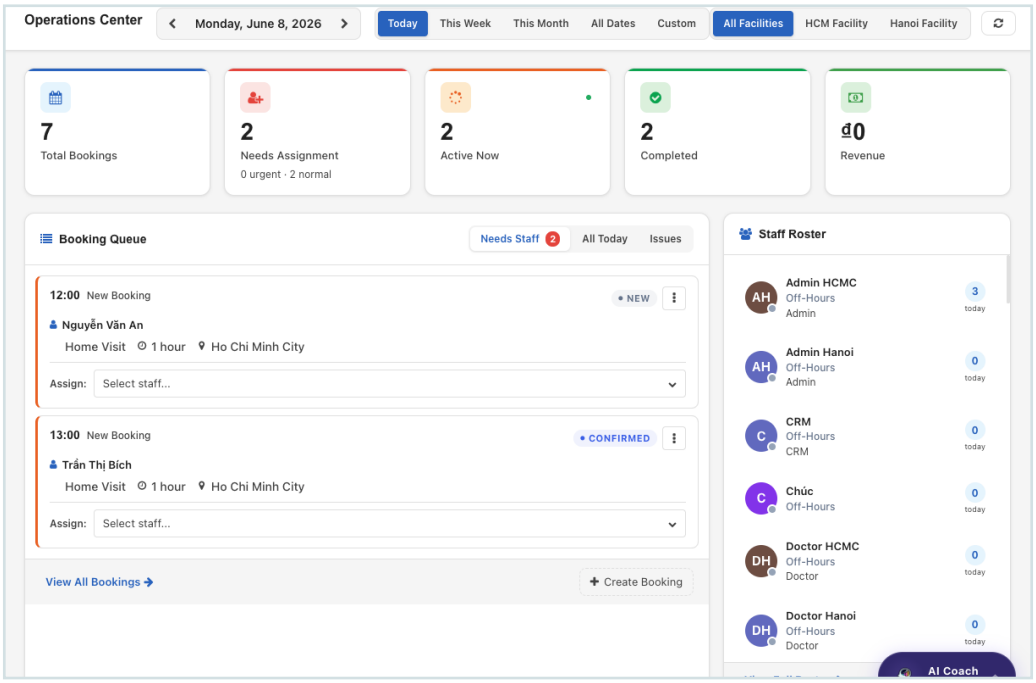
Dùng bảng tổng quan Điều phối

Lịch nhân viên, Nghỉ phép, Khối lượng và Tuyến đường

Ngoại lệ, bàn giao tiền và phát triển nhân viên

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

4.1 Dùng bảng tổng quan Điều phối



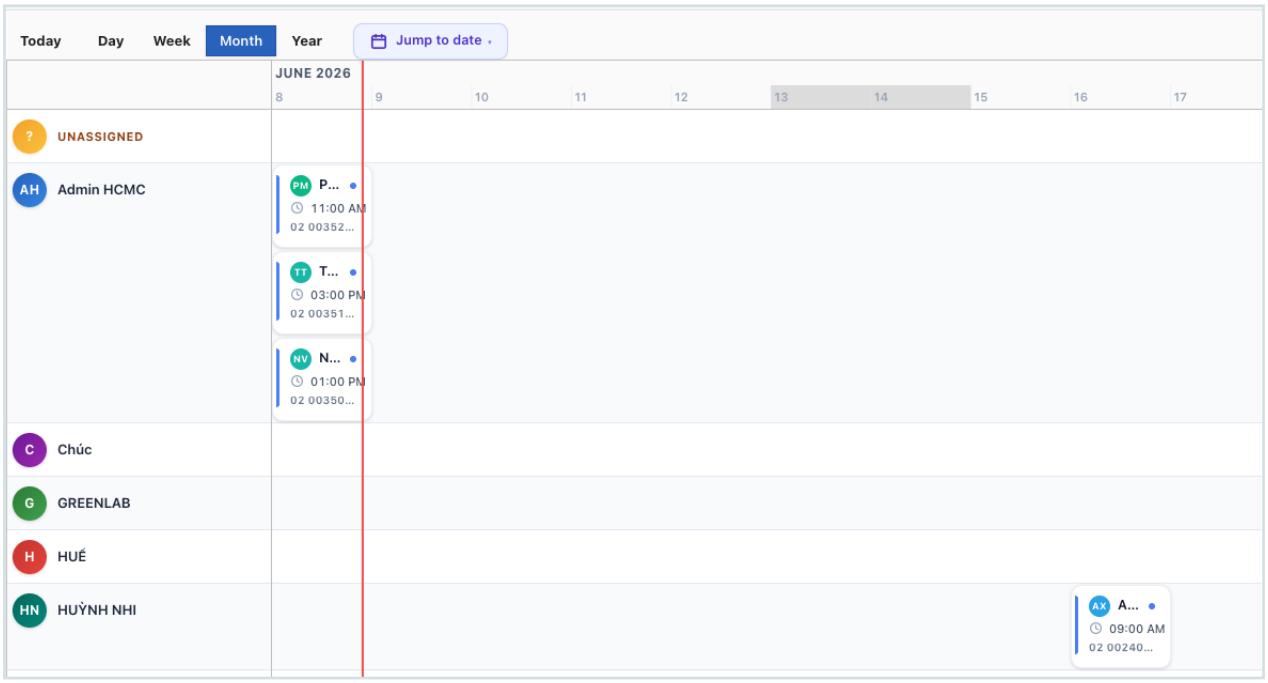
Hình 7. Tổng quan Điều phối: xem cùng hàng đợi, nhân viên và thời gian.

Bắt đầu tại Điều phối > Bảng tổng quan. Chọn ngày, cơ sở và khu vực. Xem lịch cần nhân viên, buổi khám đang thực hiện và công việc hoàn tất. Hàng đợi và trục thời gian giúp thấy bước tiếp theo mà không cần mở mọi lịch hẹn.

1. Mở lịch chưa phân công, xác nhận dịch vụ, giờ và địa điểm.
2. Kiểm tra lịch nhân viên, thời gian rảnh và khối lượng công việc. Khoảng trống trên lịch chưa đủ nếu nhân viên thiếu kỹ năng hoặc thời gian di chuyển.
3. Dùng Phân công nhân viên hoặc bộ chọn ngay trên dòng. Kiểm tra người chính và người hỗ trợ khi cần nhiều người.
4. Xác minh việc nhận lịch. Lời mời hoặc phân công chưa chứng minh nhân viên đã xem và chấp nhận.
5. Theo dõi vấn đề trong ngày và bố trí người thay khi có từ chối.

Dùng liên kết trên bảng tổng quan để mở lịch hẹn thật. Làm mới để xem dữ liệu hiện tại. Một buổi khám có thể xong về chuyên môn nhưng còn việc tài chính; theo dõi đúng danh sách cho từng việc còn lại.

4.2 Lịch nhân viên, Nghỉ phép, Khối lượng và Tuyến đường



Hình 8. Lịch nhân viên: đối chiếu giờ khám với nhân viên có thể nhận.

Lịch > Lịch nhân viên hiển thị công việc theo nhân viên và thời gian. Dùng bộ chọn ngày và cách xem để đến đúng ngày. Mở một khối để kiểm tra lịch hẹn liên kết. Nếu có tính năng kéo vùng trống để tạo lịch, thao tác đó mở bước tạo lịch hẹn; kiểm tra biểu mẫu trước khi lưu.

Nghỉ phép ghi thời gian vắng mặt. Khối lượng công việc tổng hợp mức tải. Tuyến đường kiểm tra khả năng di chuyển giữa các buổi khám. Cảnh báo tuyến đường hỗ trợ lập kế hoạch; không tự chuyển lịch và không bảo đảm giờ đến.

1. Đối chiếu buổi khám với giờ làm, nghỉ phép và phân công hiện có.
2. Chừa thời gian di chuyển thực tế. Kiểm tra cảnh báo tuyến đường, không bỏ qua chỉ vì giờ khám không chồng nhau.
3. Phân công người phù hợp và kiểm tra lịch cuối cùng.
4. Sau thay đổi, kiểm tra mọi nhân viên của buổi khám nhiều người vẫn cùng giờ hẹn.

Nếu nhân viên từ chối, mở phân công hoặc lịch hẹn để chọn người thay. Xác nhận người mới đã nhận và phân công cũ không còn là công việc đang có hiệu lực. Thông báo bố trí cuối cùng cho nhóm phụ trách.

4.3 Ngoại lệ, bàn giao tiền và phát triển nhân viên

Ngoại lệ > Lời mời buổi khám đầu giúp theo dõi lời mời phân công. Chênh lệch bảng công nêu khác biệt giữa giờ khám và chấm công. Dùng giờ buổi khám (Use Visit Times) và Giữ giờ chấm công (Keep Attendance) là hai quyết định khác nhau; kiểm tra bằng chứng và quyền trước khi chọn. Không dùng nút chỉ để làm mất cảnh báo.

Thu tiền theo dõi tiền mặt ngoài hiện trường chờ bàn giao. Đếm tiền cùng nhân viên, đối chiếu khách hàng và mã thanh toán, rồi dùng thao tác nhận tiền có quyền. Bàn giao xác nhận di chuyển số tiền đã thu, không phải một lần khách hàng thanh toán nữa.

Phát triển > Phát triển nhân viên và Huấn luyện hỗ trợ kế hoạch, mục tiêu và buổi hướng dẫn. Mở kế hoạch của nhân viên, xem mục tiêu cùng hạn đã thống nhất và ghi tiến độ. Bắt đầu phiên và Hoàn tất phiên theo dõi buổi huấn luyện. Bản tóm tắt hoặc hành động AI đề xuất cần được con người xem lại. Giữ thông tin phát triển nhân viên đúng phạm vi được phép.

Cuối ngày, kiểm tra lời mời chưa xử lý, buổi khám chưa xong, chênh lệch giờ, tiền chờ bàn giao và việc theo dõi quan trọng. Ghi người phụ trách tiếp theo để công việc liên tục giữa các ca.

CHƯƠNG 05

Ứng dụng di động cho điều dưỡng và bác sĩ

Quy trình thông thường



Trong chương này

Mở ứng dụng và tìm lịch được giao

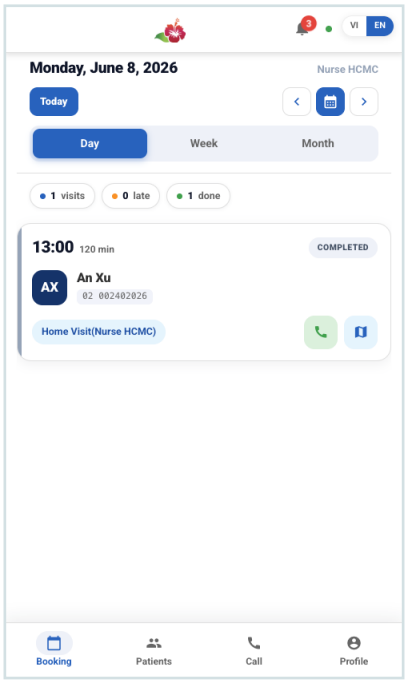
Thực hiện buổi khám từng bước

Ghi chú, nhập giọng nói, ký và xác minh

Khách hàng, cuộc gọi, tin gia đình và hồ sơ cá nhân

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

5.1 Mở ứng dụng và tìm lịch được giao



Hình 9. Di động, xem ngày: chọn ngày và mở buổi khám được giao.

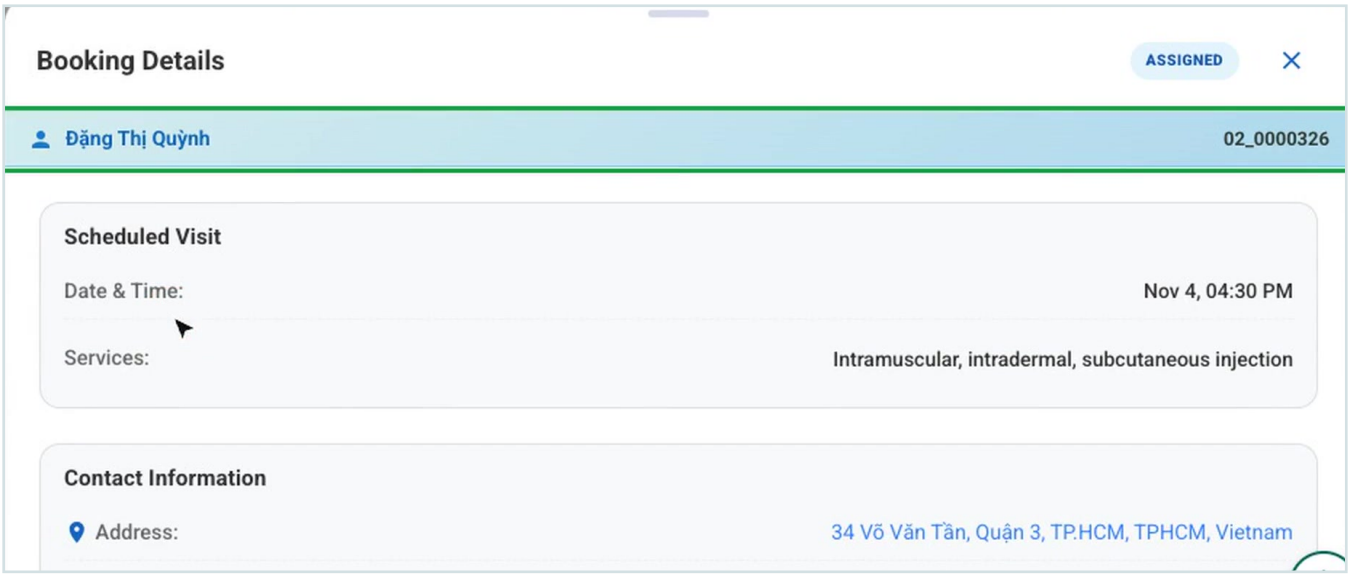
Mở https://carejiox.com/health_pwa trên điện thoại hoặc mở ứng dụng đã cài. Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Nếu trình duyệt có đề nghị cài, dùng Cài đặt hoặc Thêm vào màn hình chính. Cài đặt tạo lối mở thuận tiện, không tạo tài khoản mới.

Lịch hẹn là thẻ công việc chính. Dùng Hôm nay, mũi tên trước/sau hoặc bộ chọn ngày, rồi chọn Ngày, Tuần hoặc Tháng. Mở thẻ buổi khám để xem chi tiết. Xác nhận khách hàng, ngày, địa chỉ, dịch vụ và phân công của bạn trước khi thao tác.

Chuông hiển thị thông báo và lời mời phân công hiện có. Chấp nhận xác nhận bạn nhận việc; dùng thao tác từ chối và lý do nếu không thể nhận. Liên hệ Điều phối nếu thiếu lịch dự kiến. Ngày trống không có nghĩa phòng khám không có lịch hẹn.

Dùng EN / VI để chọn ngôn ngữ giao diện. Chế độ hiển thị giúp nhìn ngoài nắng hoặc tăng vùng chạm khi đeo găng. Hướng dẫn mở bài viết và video cạnh công việc; nội dung trực tuyến cần kết nối.

5.2 Thực hiện buổi khám từng bước



Hình 10. Chi tiết buổi khám: xác nhận khách hàng, giờ, dịch vụ và nơi đến.

1. Mở buổi khám được giao. Đọc thông tin khách hàng và hướng dẫn dịch vụ. Chỉ dùng Gọi hoặc Bản đồ sau khi kiểm tra đúng người, đúng điểm đến.
2. Dùng Đang trên đường (On my way) khi có và khi thực sự bắt đầu di chuyển. Thao tác ghi sự kiện đi đường, không bắt đầu đồng hồ dịch vụ.
3. Khi đến đúng nơi và sẵn sàng chăm sóc, chọn Bắt đầu dịch vụ. Cung cấp quyền vị trí hoặc thông tin xác minh bắt buộc nếu được yêu cầu. Kiểm tra trạng thái Đang thực hiện.
4. Mở Ghi chú lâm sàng và ghi công việc trong đúng buổi khám. Lưu, đóng khung ghi chú rồi mở lại để xác nhận còn nội dung.
5. Hoàn thành dấu hiệu sinh tồn, đánh giá, nhiệm vụ kế hoạch chăm sóc hoặc hồ sơ thuốc áp dụng cho buổi khám. Dùng thao tác dịch vụ để thêm dịch vụ bổ sung đã được phép khi cần.
6. Trả lời đúng các câu hỏi kết thúc. Chỉ chọn Hoàn tất / Hoàn tất dịch vụ khi xong công việc và hồ sơ bắt buộc.
7. Mở lại buổi khám để kiểm tra hoàn tất và hóa đơn liên kết nếu được xem. Nếu còn trạng thái chờ, đọc thông báo và hỏi Điều phối về việc còn lại.

Nếu nhiều người cùng tham gia, làm theo trách nhiệm chính/hỗ trợ trên phân công. Không bắt đầu hoặc hoàn tất phần của người khác chỉ để bỏ lỗi.

5.3 Ghi chú, nhập giọng nói, ký và xác minh

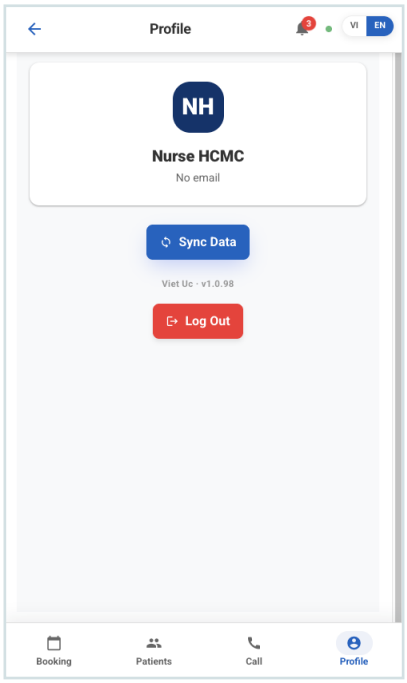
Ghi quan sát thực tế và chăm sóc đã thực hiện trong đúng buổi khám của khách hàng. Nhập giọng nói, khi bật, chuyển lời ghi âm của bạn thành văn bản nháp. Đọc toàn bộ bản chép, sửa tên, số và ý nghĩa rồi lưu ghi chú đã kiểm tra. Bản ghi âm hoặc bản chép chưa phải hồ sơ lâm sàng đã ký.

Hoàn tất và ký (Finalize & Sign) là thao tác riêng của người có thẩm quyền. Kiểm tra nội dung trước khi ký. Ghi chú cuối cùng được bảo vệ khỏi sửa thông thường; dùng quy trình bổ sung được phép để sửa về sau thay vì ghi đè bản gốc.

Xác minh buổi khám có thể ghi giờ vào/ra, vị trí và chữ ký. Nếu không có vị trí hoặc vị trí sai, giải thích vấn đề và liên hệ Điều phối. Không tự bịa tọa độ hoặc ký thay người khác. Buổi khám trực tuyến theo quy trình khám từ xa đã cấu hình.

Khi mất kết nối, đọc trạng thái mạng hoặc chờ đồng bộ. Một số dữ liệu có thể có trên máy, nhưng video, cuộc gọi trực tiếp và thao tác máy chủ cần mạng. Kết nối lại, dùng Đồng bộ dữ liệu nếu có rồi mở lại để kiểm tra. Không đăng xuất, xóa dữ liệu trình duyệt hoặc cài lại khi còn việc chưa gửi. Nếu không rõ đã lưu hay chưa, kiểm tra trước khi nhập lại.

5.4 Khách hàng, cuộc gọi, tin gia đình và hồ sơ cá nhân



Hình 11. Hồ sơ cá nhân: kiểm tra người đăng nhập trước đồng bộ hoặc đăng xuất.

Khách hàng cung cấp danh sách tìm kiếm trong phạm vi quyền. Mở đúng người và xem thông tin được phép. Thẻ Gọi mở cách liên hệ phòng khám; nút Gọi trên buổi khám liên hệ người của buổi khám đó. Kiểm tra số trước khi gọi.

Tin nhắn gia đình, khi được bật trong buổi khám, cho phép nhóm chăm sóc đọc và trả lời hội thoại được phép. Kiểm tra người nhận và nội dung trước khi gửi. Sau khi hoàn tất có thể có chức năng cập nhật cho gia đình; kiểm tra nội dung cùng yêu cầu đồng ý. Không khẳng định tin đã được giao chỉ vì đã có bản nháp.

Hồ sơ cá nhân cho biết danh tính đang đăng nhập và điều khiển đồng bộ/đăng xuất. Dùng Đồng bộ dữ liệu để yêu cầu làm mới và kiểm tra việc đang chờ. Đăng xuất kết thúc phiên và có thể xóa thông tin khách hàng lưu trên máy; trước đó cần xác nhận thay đổi đã lên máy chủ.

Thông báo phụ thuộc quyền thiết bị và thiết lập gửi của phòng khám. Nếu thông báo bị chặn, làm theo hướng dẫn trong ứng dụng và tiếp tục tự kiểm tra danh sách công việc. Không nhận thông báo không có nghĩa phân công đã bị hủy.

CHƯƠNG 06

Hồ sơ lâm sàng và phối hợp chăm sóc

Quy trình thông thường



Trong chương này

Dấu hiệu sinh tồn và quan sát

Thông tin chăm sóc: danh sách ưu tiên, cảnh báo và NEWS2

Kế hoạch chăm sóc và nhiệm vụ buổi khám

Y lệnh thuốc và sổ thực hiện thuốc

Đánh giá và biểu mẫu lâm sàng

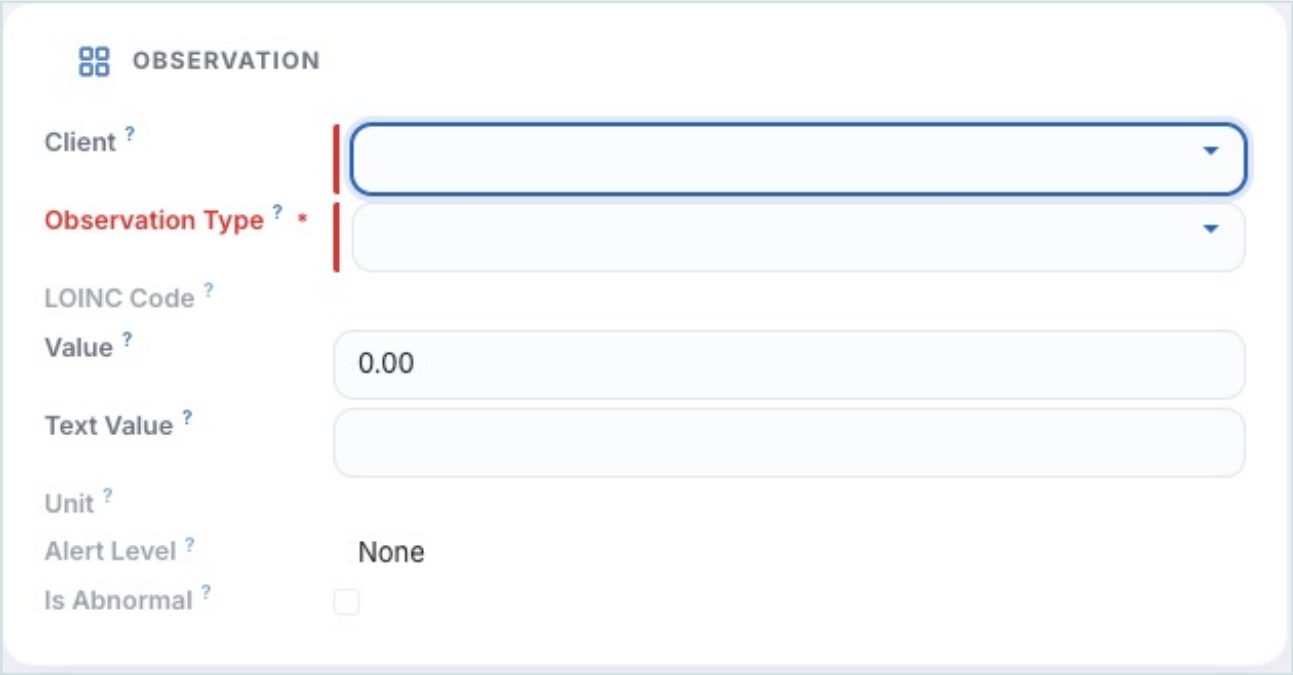
Ghi chú, chẩn đoán và duyệt mã

Sự đồng ý và quyền chia sẻ

Báo cáo sự cố và theo dõi khắc phục

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

6.1 Dấu hiệu sinh tồn và quan sát



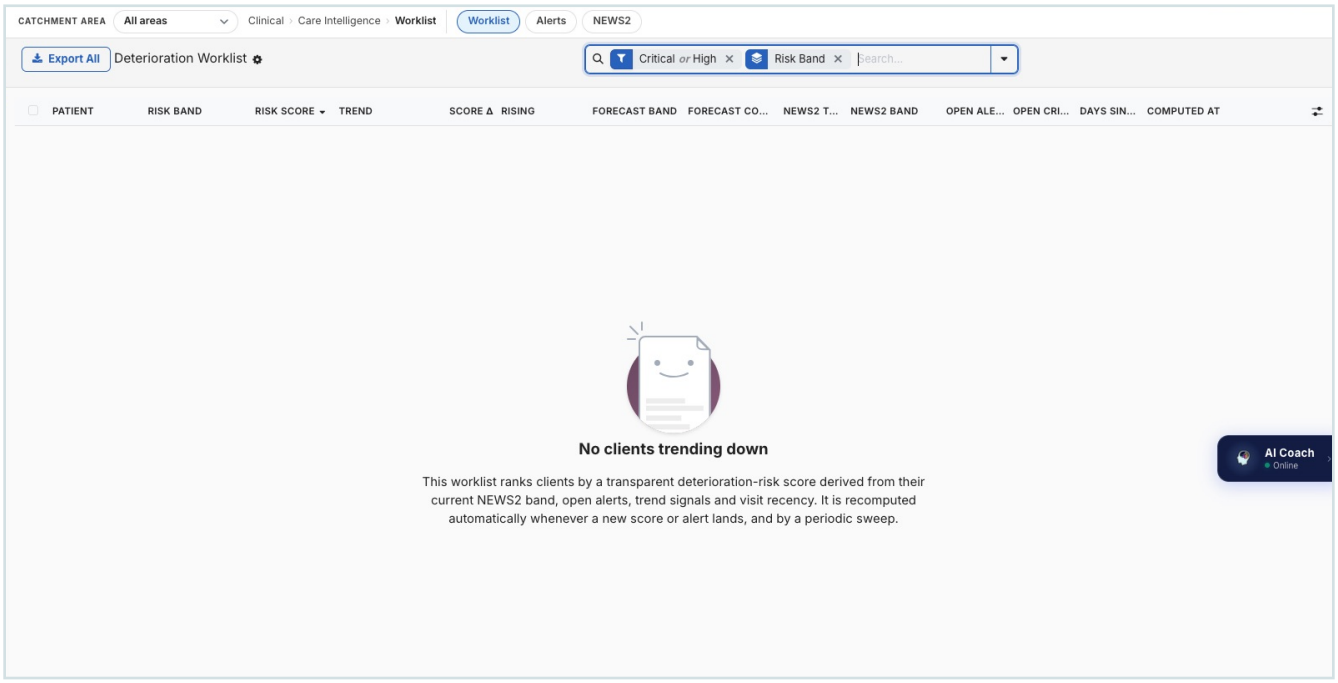
Hình 12. Nhập quan sát: chọn khách hàng, loại đo rồi nhập giá trị thực tế.

Lâm sàng > Quan sát lưu các phép đo có cấu trúc. Khác ghi chú tự do, mỗi quan sát có loại, giá trị, đơn vị và thời điểm. Nhờ đó có thể xem xu hướng và dùng số đo trong theo dõi.

1. Mở đúng khách hàng hoặc buổi khám và tạo quan sát bằng thao tác hiện có.
2. Chọn loại quan sát. Nhập giá trị đã đo theo đơn vị hiển thị; không đoán hoặc chép số đo cũ thành kết quả mới.
3. Kiểm tra thời điểm có hiệu lực, người thực hiện, liên kết buổi khám và phương pháp hoặc tư thế liên quan.
4. Lưu, xem kết quả và dấu hiệu bất thường/cảnh báo. Nếu nhập sai, dùng quy trình sửa hoặc Đã nhập nhầm được phép thay vì che lỗi.
5. Theo quy trình báo cáo của phòng khám khi có kết quả đáng lo. Ghi một giá trị không đồng nghĩa đã báo người phụ trách chuyên môn.

Phần mềm hỗ trợ ghi nhận và xem xét, không quyết định chăm sóc cần thực hiện. Không xem kết quả thiếu hoặc cũ là kết quả bình thường hiện tại.

6.2 Thông tin chăm sóc: danh sách ưu tiên, cảnh báo và NEWS2



Hình 13. Thông tin chăm sóc: dùng thẻ danh sách ưu tiên, cảnh báo và NEWS2 để xem xét.

Danh sách ưu tiên tập hợp khách hàng có thể cần xem xét dựa trên tín hiệu theo dõi hiện có. Mở một dòng để xem lý do, ngày giờ và số đo hỗ trợ. Thứ hạng giúp tổ chức công việc, không phải chẩn đoán.

Cảnh báo có trạng thái riêng. Đã tiếp nhận (Acknowledge) nghĩa là có người nhận trách nhiệm xem xét. Giải quyết (Resolve) ghi việc đã xử lý. Bỏ qua có lý do (Dismiss) ghi cảnh báo không áp dụng, kèm giải thích bắt buộc. Tiếp nhận không có nghĩa tình trạng khách hàng đã cải thiện.

NEWS2 hiển thị điểm hiện có và các số đo thành phần. Kiểm tra thời điểm đo và việc có đủ thành phần cần thiết không. Không xem dữ liệu thiếu là điểm an toàn. Sổ tay giải thích màn hình, không quy định ngưỡng lâm sàng hay quyết định điều trị.

1. Xem mục ưu tiên cao hoặc mới nhất theo quy trình phòng khám.

2. Xác nhận khách hàng và bằng chứng, liên hệ người phụ trách chuyên môn khi cần.

3. Ghi hành động đã thực hiện và cập nhật cảnh báo bằng nút được phép.

4. Bố trí, ghi nhận theo dõi tiếp. Báo riêng lỗi thiết bị hoặc nguồn dữ liệu với vấn đề lâm sàng.

6.3 Kế hoạch chăm sóc và nhiệm vụ buổi khám

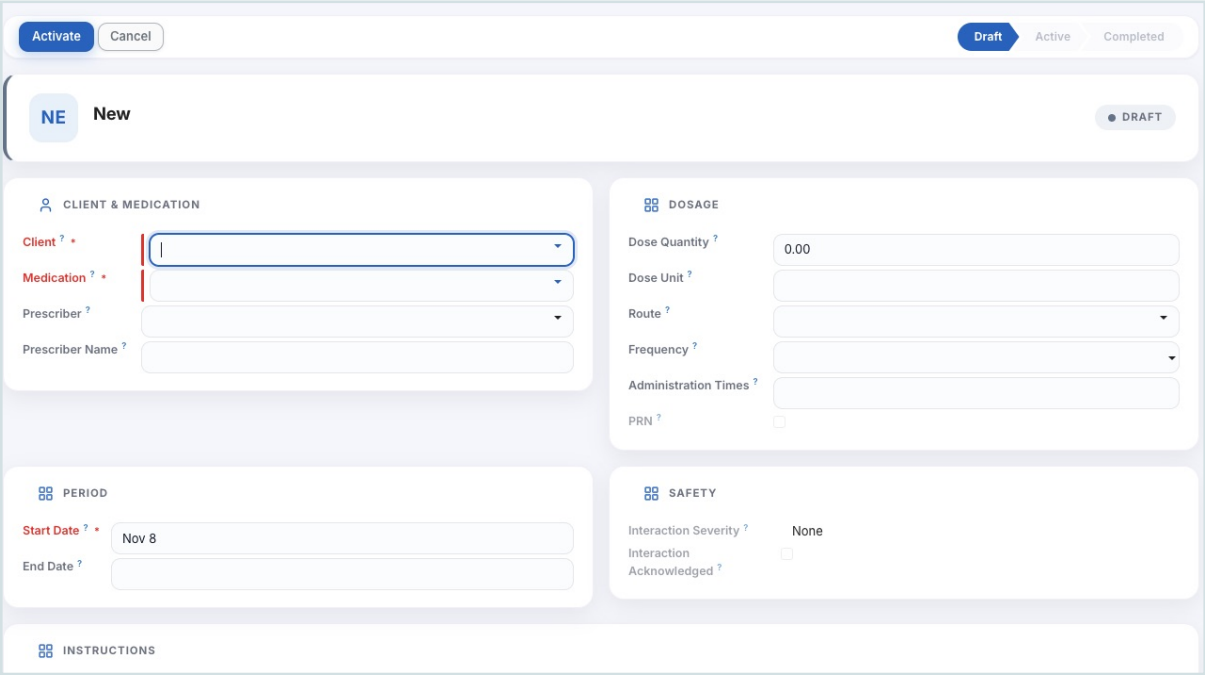
Kế hoạch chăm sóc mô tả mục tiêu và hoạt động dự kiến theo thời gian. Nhiệm vụ buổi khám là một việc cụ thể cần làm trong một lần khám. Mở thẻ Kế hoạch chăm sóc của khách hàng hoặc thao tác kế hoạch theo quyền. Thẻ Nhiệm vụ buổi khám hiển thị công việc liên quan.

Người phụ trách chuyên môn có quyền chuẩn bị kế hoạch, mục tiêu, hoạt động và ngày rà soát. Kích hoạt đưa kế hoạch vào sử dụng. Bắt đầu rà soát và Xác nhận rà soát ghi quá trình đánh giá lại. Hoàn tất kết thúc kế hoạch; Hủy kế hoạch dừng theo quy trình phù hợp.

Trong buổi khám, đọc từng nhiệm vụ và ghi kết quả thật. Đánh dấu đã làm nghĩa là đã thực hiện. Đánh dấu chưa làm ghi việc không thực hiện; nhập lý do được yêu cầu. Không đánh dấu tất cả đã làm chỉ để xong màn hình. Đặt lại chờ xử lý dùng cho sửa đổi được phép, không để xóa diễn biến.

Kiểm tra khách hàng, kế hoạch đang hiệu lực và buổi khám trước khi ghi kết quả. Nếu kế hoạch cũ hoặc nhiệm vụ không phù hợp, liên hệ người phụ trách chuyên môn và ghi vấn đề. Sửa kế hoạch khác với ghi hoàn thành một nhiệm vụ buổi khám.

6.4 Y lệnh thuốc và sổ thực hiện thuốc



Hình 14. Y lệnh thuốc: kiểm tra trạng thái và hướng dẫn trước khi kích hoạt.

Lâm sàng > Thuốc > Y lệnh chứa hướng dẫn dùng thuốc. Sổ thực hiện thuốc ghi từng lần dự kiến hoặc thực tế. Có y lệnh chưa phải bằng chứng đã dùng thuốc.

Người có quyền kê đơn kiểm tra khách hàng, thuốc, liều, đường dùng, tần suất, ngày bắt đầu/kết thúc và hướng dẫn. Kích hoạt đưa y lệnh đã duyệt vào sử dụng. Tạm ngưng dừng tạm; Tiếp tục mở lại; Hoàn tất hoặc Hủy kết thúc theo tình huống. Cảnh báo tương tác và xác nhận đã xem cần đánh giá chuyên môn, không chỉ bấm cho qua.

Với một lần dùng thuốc dự kiến, xác nhận đúng khách hàng, buổi khám, thuốc và y lệnh trước khi ghi diễn biến. Ghi đã dùng (Record Given) ghi lần thực tế đã thực hiện. Ghi chưa dùng hoặc Ghi từ chối ghi kết quả khác cùng lý do. Hủy lượt là thao tác lịch, không chứng minh đã dùng thuốc.

Kiểm tra kết quả và giờ đã lưu trong sổ. Nếu nhập nhầm hoặc y lệnh mâu thuẫn hướng dẫn chăm sóc, dừng và chuyển người phụ trách chuyên môn theo quy trình. Màn hình ghi công việc thuốc được phép, không hướng dẫn chọn thuốc hoặc liều.

6.5 Đánh giá và biểu mẫu lâm sàng

Lâm sàng > Đánh giá và thẻ Đánh giá của buổi khám lưu biểu mẫu đang làm hoặc đã hoàn tất. Mẫu đã công bố quy định câu hỏi, kiểu trả lời và cách tính điểm nếu có.

1. Mở đúng buổi khám, chọn Đánh giá mới nếu có. Chọn mẫu phù hợp và xác nhận khách hàng.
2. Trả lời câu hỏi liên quan theo kiểu yêu cầu: văn bản, số, ngày, lựa chọn, ảnh hoặc chữ ký. Dùng đơn vị hiển thị.
3. Xem câu hỏi bắt buộc và điểm hoặc mức phân loại. Điểm tính dựa trên dữ liệu đã nhập; nhập sai tạo kết quả gây hiểu nhầm.
4. Lưu việc chưa xong theo chức năng được phép. Chỉ chọn Hoàn tất sau khi kiểm tra câu trả lời.
5. Mở lại, xác minh trạng thái và liên kết đến quan sát được trích xuất nếu có.

Không đổi mẫu để tránh trả lời. Hỏi người phụ trách chuyên môn hoặc quản trị biểu mẫu nếu câu hỏi không phù hợp hay thiếu lựa chọn. Chữ ký phải do đúng người cung cấp, không sao chép từ hồ sơ khác.

6.6 Ghi chú, chẩn đoán và duyệt mã

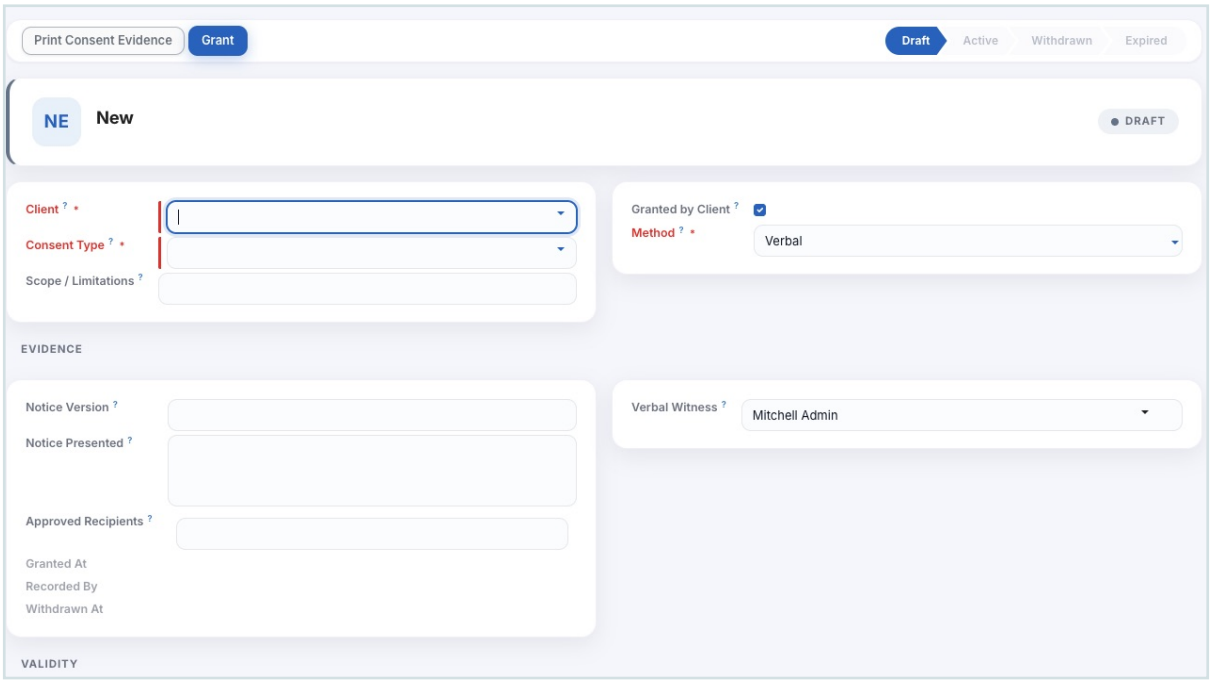
Lâm sàng > Ghi chú nhóm Ghi chú chưa ký, Ghi chú giọng nói và Duyệt mã. Ghi chú chưa ký giúp người có quyền tìm nội dung cần kiểm tra cuối. Ghi chú giọng nói hiển thị tác vụ chép lời và trạng thái. Kiểm tra tác vụ lỗi hoặc chờ trước khi ghi âm lại.

Duyệt mã chứa mã y khoa được gợi ý. Người duyệt có quyền đọc ghi chú nguồn và mã đề xuất, rồi chọn Chấp thuận hoặc Từ chối. Chấp thuận là quyết định chủ động của con người; gợi ý AI không tự trở thành chẩn đoán xác nhận.

Thẻ Chẩn đoán của khách hàng liên kết bệnh lý với thông tin hỗ trợ. Đã giải quyết, Không còn hoạt động và Kích hoạt lại đổi trạng thái lâm sàng. Chỉ người phụ trách chuyên môn phù hợp nên thực hiện. Đọc bằng chứng và ngày trước khi diễn giải danh sách bệnh lý.

Nếu ghi chú đã ký cần sửa, dùng đường bổ sung được phép. Giữ nguyên bản ghi diễn biến ban đầu và giải thích phần sửa. Nếu không thấy nút ký hoặc chẩn đoán, nhờ người phụ trách chuyên môn thay vì xin quyền rộng chỉ để hoàn tất màn hình.

6.7 Sự đồng ý và quyền chia sẻ



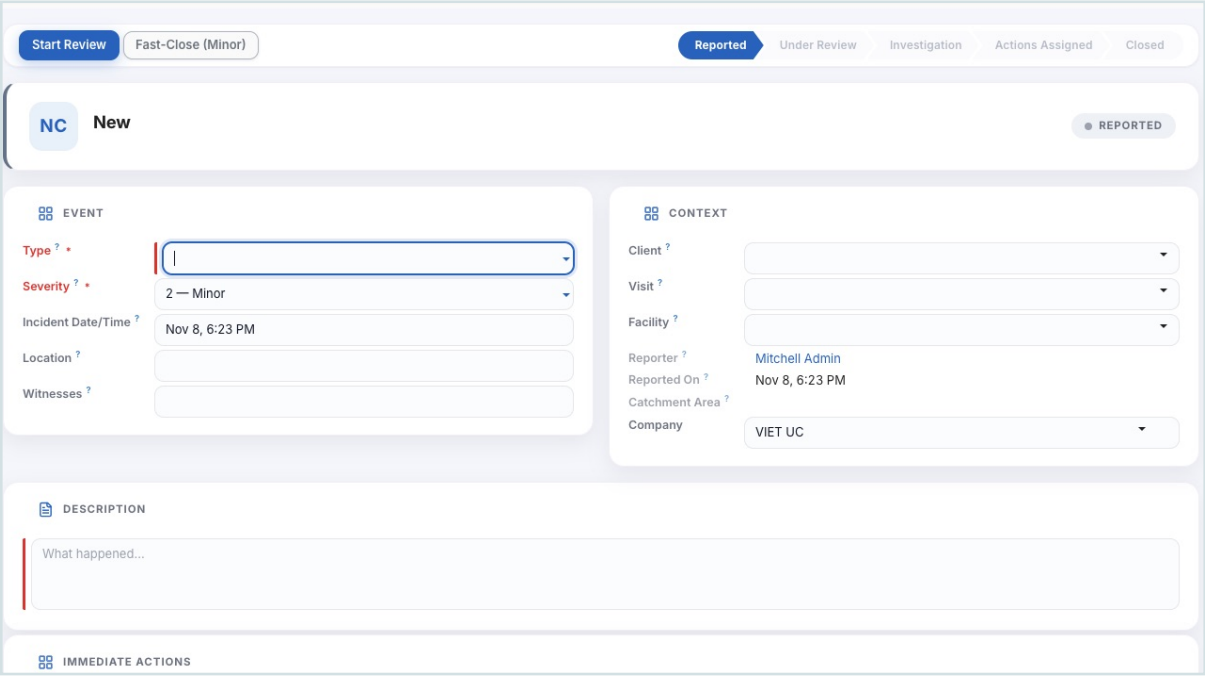
Hình 15. Biểu mẫu đồng ý: xác định mục đích, người và bằng chứng.

Lâm sàng > Đồng ý giúp xem hồ sơ đồng ý, kể cả hồ sơ gần hết hạn. Sự đồng ý áp dụng cho mục đích cụ thể, không phải quyền vô thời hạn cho mọi hoạt động.

1. Xác nhận khách hàng, mục đích, người đồng ý, mối quan hệ và hình thức.
2. Ghi bằng chứng, ngày và thời hạn bắt buộc. Giải thích thông tin với đúng người theo quy trình phòng khám.
3. Chỉ dùng Cấp / Ghi nhận đồng ý (Grant) khi thực sự có đồng ý hợp lệ và bạn có quyền ghi nhận.
4. Kiểm tra trạng thái hiệu lực và hạn trước hành động liên quan. Rút lại (Withdraw) ghi việc rút đồng ý, không xóa lịch sử.
5. In bằng chứng đồng ý có thể tạo bản ghi bằng chứng khi được phép.

Người thân có tên trên hồ sơ không tự có quyền nhận toàn bộ hồ sơ. Nếu tin gia đình, liên kết cổng khách hàng hoặc thao tác khác bị chặn vì thiếu đồng ý, giải quyết quyền với nhóm phụ trách. Không lách bằng cách gửi qua kênh không liên quan.

6.8 Báo cáo sự cố và theo dõi khắc phục



Hình 16. Biểu mẫu sự cố: ghi sự kiện và dùng đúng giai đoạn xem xét.

Dùng Lâm sàng > Sự cố > Sổ sự cố để ghi sự kiện ảnh hưởng chăm sóc hoặc an toàn dịch vụ. Trước hết xử lý nhu cầu tức thời theo quy trình phản ứng của phòng khám; nhập biểu mẫu không thay cho thông báo khẩn.

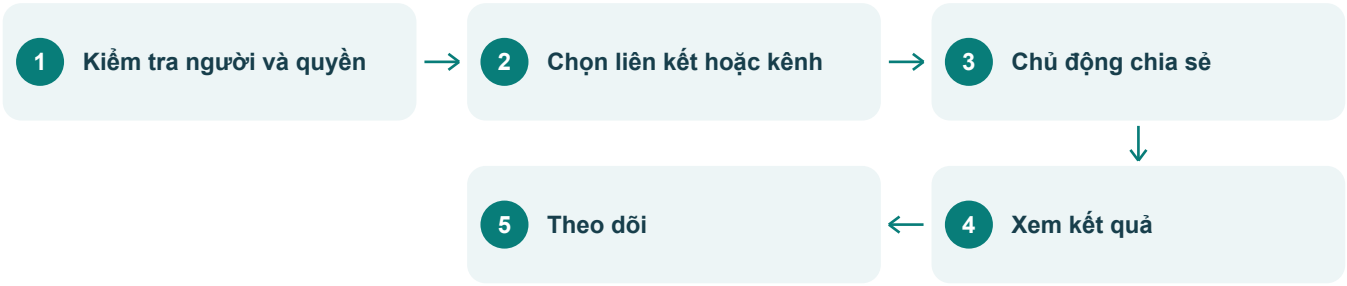
1. Tạo sự cố với đúng khách hàng, buổi khám, ngày giờ, loại, mức độ và mô tả sự thật. Ghi hành động ban đầu và bằng chứng liên quan.
2. Lưu, thông báo người phụ trách xem xét theo đường đã thống nhất.
3. Người duyệt dùng Bắt đầu xem xét, rồi Bắt đầu điều tra khi cần. Ghi kết quả và giao hành động khắc phục có người phụ trách, hạn.
4. Dùng Hành động khắc phục để theo dõi. Bắt đầu và Đánh dấu hoàn tất thể hiện tiến độ; ghi hoặc đính kèm bằng chứng hoàn thành.
5. Chỉ đóng sự cố khi xong đánh giá và hành động phù hợp. Đóng nhanh (nhẹ) là lối tắt hạn chế cho trường hợp nhẹ đủ điều kiện, không để bỏ qua xem xét sự cố nghiêm trọng. Mở lại dùng khi còn việc cần làm.

Phân tích tổng hợp thông tin sự cố. Kiểm tra khoảng ngày và phân loại trước khi so sánh số liệu.

CHƯƠNG 07

Khám từ xa và liên lạc gia đình

Quy trình thông thường



Trong chương này

Khám từ xa và tự đặt lịch

Hộp thư gia đình, liên kết buổi khám và My Care

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

7.1 Khám từ xa và tự đặt lịch

Với buổi khám trực tuyến, xác nhận đúng loại dịch vụ và giờ trên lịch hẹn. Mở phiên hoặc dùng Tham gia video khi có. Kiểm tra quyền mic/camera và đúng người tham gia trước khi trao đổi chăm sóc. Khách hàng có thể vào qua liên kết phòng chờ. Nếu nhà cung cấp video chưa được cấu hình hoặc kết nối lỗi, liên hệ phòng khám, ghi phương án thay thế đã thống nhất; không đánh dấu hoàn tất chỉ vì đã mở màn hình gọi.

Tự đặt lịch dùng lời mời dành cho khách hàng cụ thể. Khi có nút Gửi liên kết tự đặt lịch, xác nhận người nhận và dịch vụ/ngày được phép trước khi gửi. Khách hàng dùng liên kết chọn khung giờ được đề xuất. Kiểm tra lịch tạo ra trong Điều phối và bố trí nhân viên theo yêu cầu.

Có liên kết chưa chứng minh đã được sử dụng. Khung giờ được đề xuất không phải buổi khám đã hoàn thành. Dùng trạng thái lịch hẹn và phiên để xác nhận tiến độ. Không sao chép liên kết riêng của khách hàng cho người khác.

7.2 Hộp thư gia đình, liên kết buổi khám và My Care

Hộp thư gia đình hỗ trợ liên lạc hai chiều được phép giữa nhóm chăm sóc và gia đình khách hàng. Mở hội thoại, xác nhận khách hàng và người nhận liên kết, đọc tin trước rồi trả lời. Đánh dấu đã đọc chỉ ghi đã xem tin, không có nghĩa việc được yêu cầu đã hoàn tất.

Liên kết buổi khám cho gia đình cung cấp phạm vi xem giới hạn của một buổi khám. My Care là cổng khách hàng; thông tin có sẵn tùy tính năng và quyền. Coi cả hai là liên kết riêng tư. Chỉ chia sẻ theo cách được duyệt cho đúng người. Nếu liên kết sai, hết hạn hoặc không còn phù hợp, nhờ người có quyền thu hồi hoặc thay thế.

1. Kiểm tra danh tính, mối quan hệ và đồng ý còn hiệu lực trước khi chia sẻ.

2. Xem nội dung cập nhật buổi khám hoặc tin trả lời.

3. Gửi một lần, kiểm tra trạng thái gửi hoặc hội thoại.

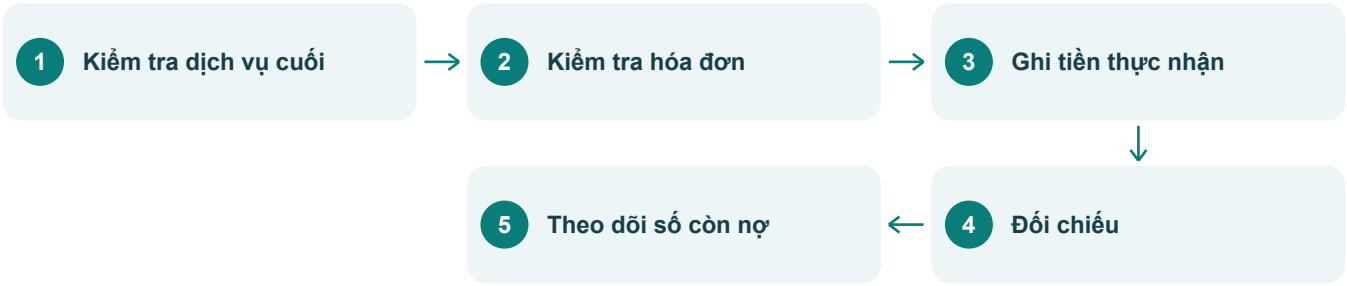
4. Ghi công việc cần làm vào hồ sơ chăm sóc hoặc lịch hẹn, không chỉ trong trò chuyện.

Tin gia đình không tự là chỉ định thay đổi chăm sóc. Chuyển câu hỏi chuyên môn và vấn đề khẩn cho người phụ trách theo quy trình phòng khám.

CHƯƠNG 08

Tài chính: hóa đơn, thanh toán và số dư

Quy trình thông thường



Trong chương này

Đọc Tài chính và trạng thái hóa đơn

Kiểm tra và lập đúng hóa đơn

Nhận thanh toán toàn bộ hoặc một phần

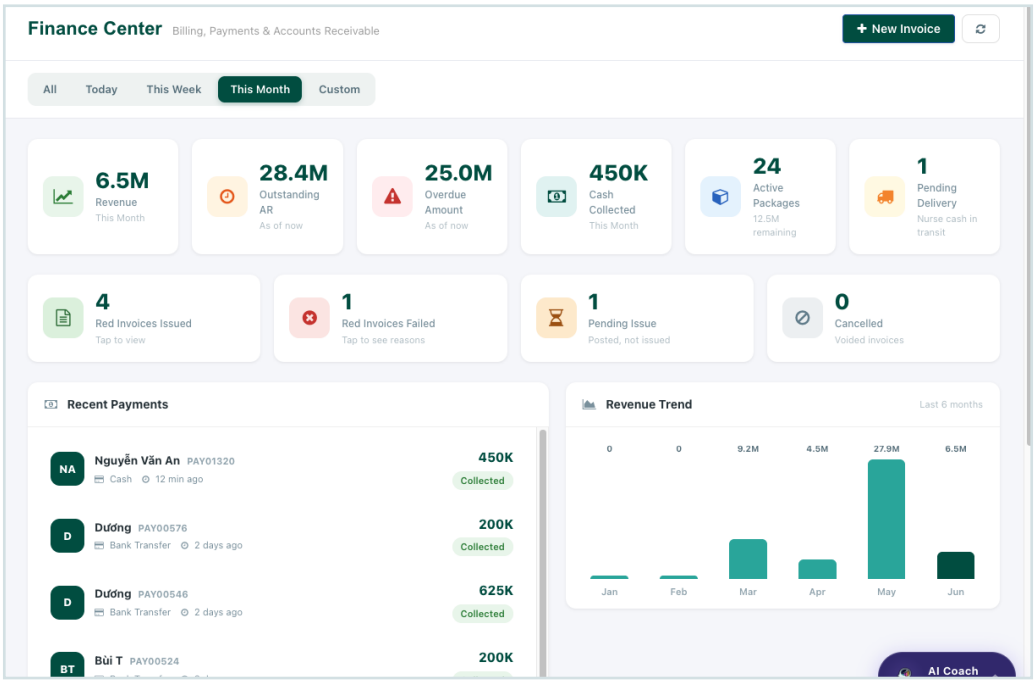
Tiền mặt hiện trường, nhận tại văn phòng và đối chiếu

Công nợ, hoàn tiền, ghi có và gói dịch vụ

Nhật ký VAT, hóa đơn điện tử và hồ sơ BHYT

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

8.1 Đọc Tài chính và trạng thái hóa đơn



Hình 17. Tổng quan Tài chính: xem kỳ, phân biệt tiền còn nợ với tiền đã nhận.

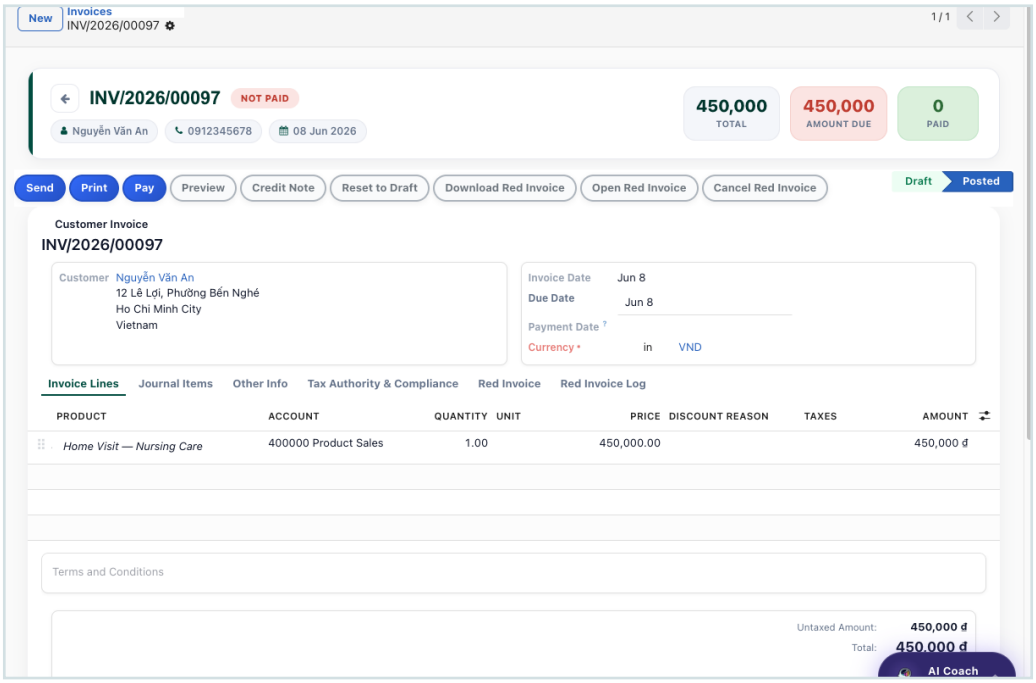
Tài chính > Bảng tổng quan tóm tắt hóa đơn, công nợ, thanh toán và tiền mặt ngoài hiện trường. Chọn kỳ trước. Dùng ô thống kê hoặc liên kết danh sách để xem hồ sơ gốc. Tài chính > Hóa đơn là danh sách xử lý chứng từ tính phí.

Nhãn	Ý nghĩa công việc
Nháp	Đang chuẩn bị hóa đơn, cần kiểm tra.
Đã ghi sổ	Hóa đơn đã được xác nhận trong hồ sơ kế toán.
Thanh toán một phần	Đã áp dụng khoản thanh toán nhưng còn dư nợ.
Đã thanh toán	Số dư ghi nhận trên hóa đơn đã được tất toán.
Quá hạn	Còn số phải trả sau ngày đến hạn.
Đã hủy	Chứng từ đã được hủy theo quy trình cho phép.

Trạng thái chứng từ khác trạng thái thanh toán. Hóa đơn có thể đã ghi sổ nhưng mới trả một phần. Mở để kiểm tra khách hàng, mã hóa đơn, ngày đến hạn, tiền tệ, dòng dịch vụ, thuế, tổng và số còn nợ. Trạng thái nhà cung cấp hóa đơn điện tử lại là trạng thái riêng.

Không suy ra cách hạch toán hoặc xử lý thuế chỉ từ nhãn tổng quan. Theo quy trình tài chính được duyệt và chi tiết của chứng từ gốc.

8.2 Kiểm tra và lập đúng hóa đơn

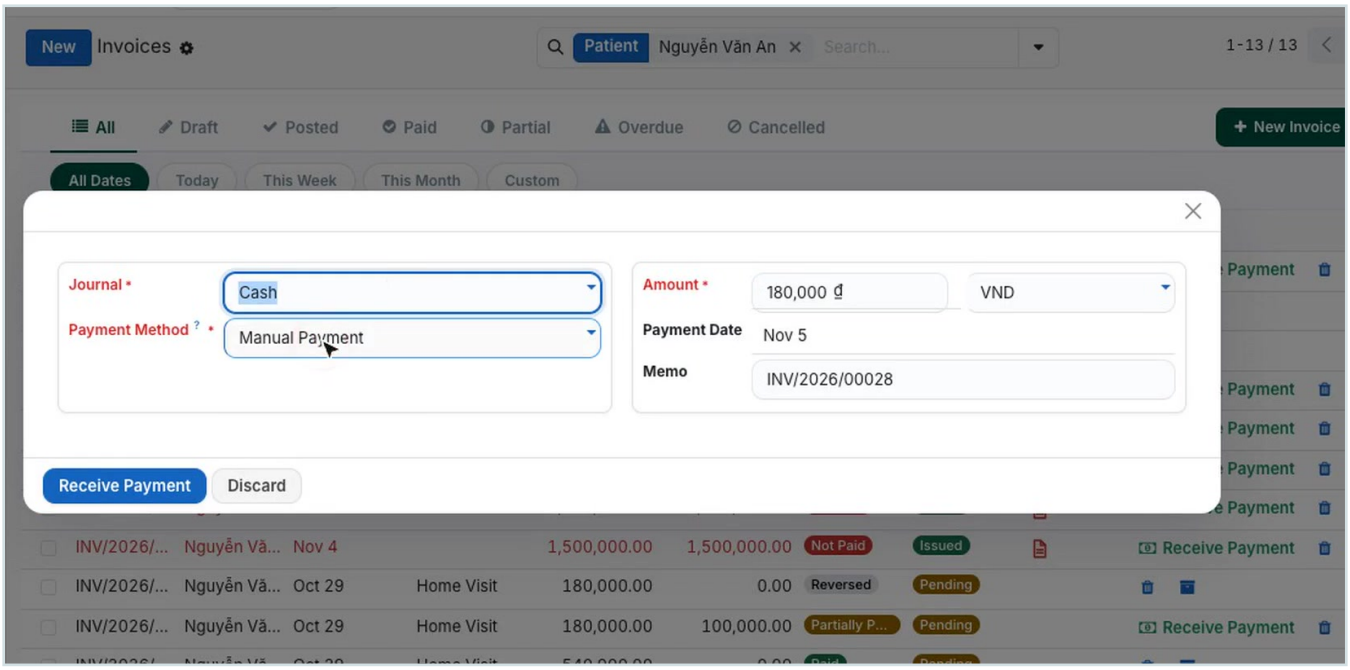


Hình 18. Chi tiết hóa đơn: xem trạng thái chứng từ, dòng, tổng và thanh toán.

1. Mở lịch hẹn và tìm hóa đơn đã có trước. Thao tác hoàn tất có thể đã tạo hóa đơn.
2. Nếu cần tạo và bạn có quyền, dùng Tạo hóa đơn từ lịch hẹn hoặc báo giá liên quan. Xác minh đúng khách hàng và mã nguồn.
3. Kiểm tra số lượng, đơn giá, chiết khấu, phí đi lại/thời gian, thông tin thuế và tổng. Đối chiếu dịch vụ cuối cùng đã ghi nhận.
4. Sửa bản nháp còn được sửa theo quy trình. Nếu chứng từ đã ghi sổ bị sai, dùng cách điều chỉnh/ghi có được duyệt thay vì sửa lịch sử.
5. Chỉ Xác nhận hoặc Ghi sổ sau kiểm tra. Xem trạng thái hóa đơn và số còn nợ sau thao tác.
6. Cung cấp hóa đơn hoặc biên nhận được phép cho đúng người. Giữ mã hóa đơn nội bộ để khớp thanh toán về sau.

Không tạo hóa đơn thứ hai vì hóa đơn đầu chưa trả hoặc yêu cầu hóa đơn điện tử đang chờ. Những vấn đề đó thuộc theo dõi thanh toán hoặc xử lý hóa đơn điện tử.

8.3 Nhận thanh toán toàn bộ hoặc một phần



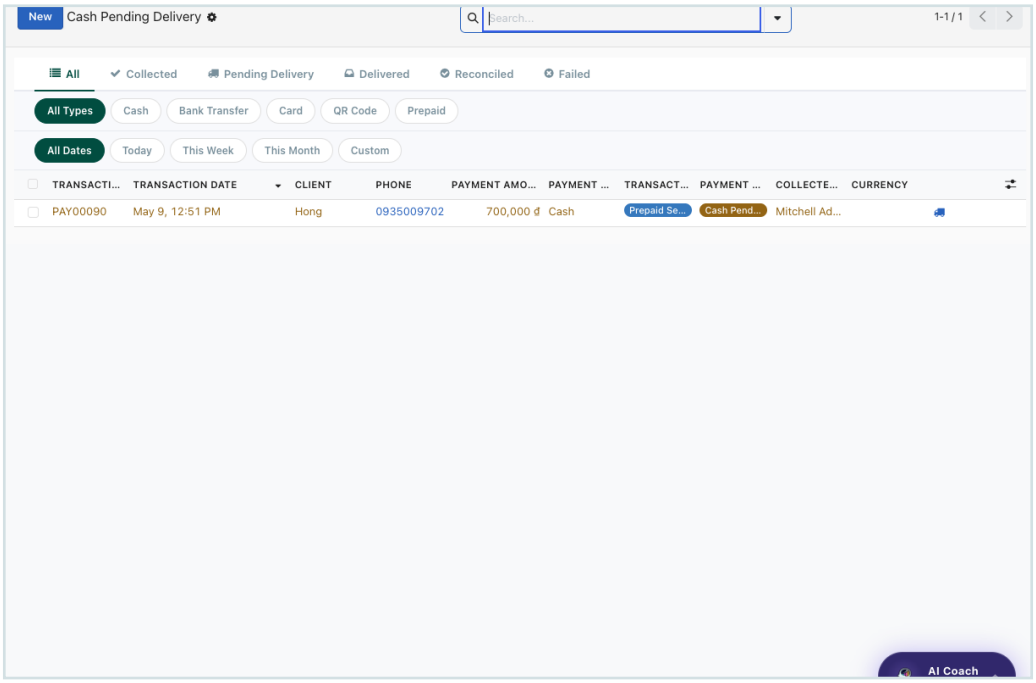
Hình 19. Quy trình thanh toán: chọn đúng hóa đơn, ghi số tiền thực nhận.

Dùng Tài chính > Thanh toán > Thanh toán tài khoản hoặc thao tác thanh toán trên hóa đơn theo vai trò. Chỉ ghi tiền khi đã thực nhận hoặc xác minh theo quy trình được duyệt.

1. Xác nhận khách hàng và mã hóa đơn. Kiểm tra số còn phải trả.
2. Nhập số tiền thực nhận, ngày, phương thức và mã tham chiếu. Chọn sổ nhật ký hoặc tài khoản nhận phù hợp khi được yêu cầu.
3. Kiểm tra cách phân bổ tiền. Khoản trả nhỏ hơn phải để lại số dư đúng, không làm cả hóa đơn thành đã trả.
4. Xác nhận rồi mở lại hóa đơn và hồ sơ thanh toán. Xem trạng thái, số còn nợ và tình trạng đối chiếu.
5. Với chuyển khoản, khớp bằng chứng ngân hàng và tham chiếu trước khi ghi tất toán. Với tiền mặt, xác định người nhận và giữ tiền.

Ví dụ: hóa đơn 1.000.000 VND, khách trả 400.000 VND. Còn 600.000 VND trước các điều chỉnh khác đã được duyệt. Ghi một khoản thực nhận khác về sau để tất toán; không đổi khoản đầu thành toàn bộ giá trị hóa đơn.

8.4 Tiền mặt hiện trường, nhận tại văn phòng và đối chiếu



Hình 20. Thu tiền: xem tiền nhân viên giữ và trạng thái bàn giao.

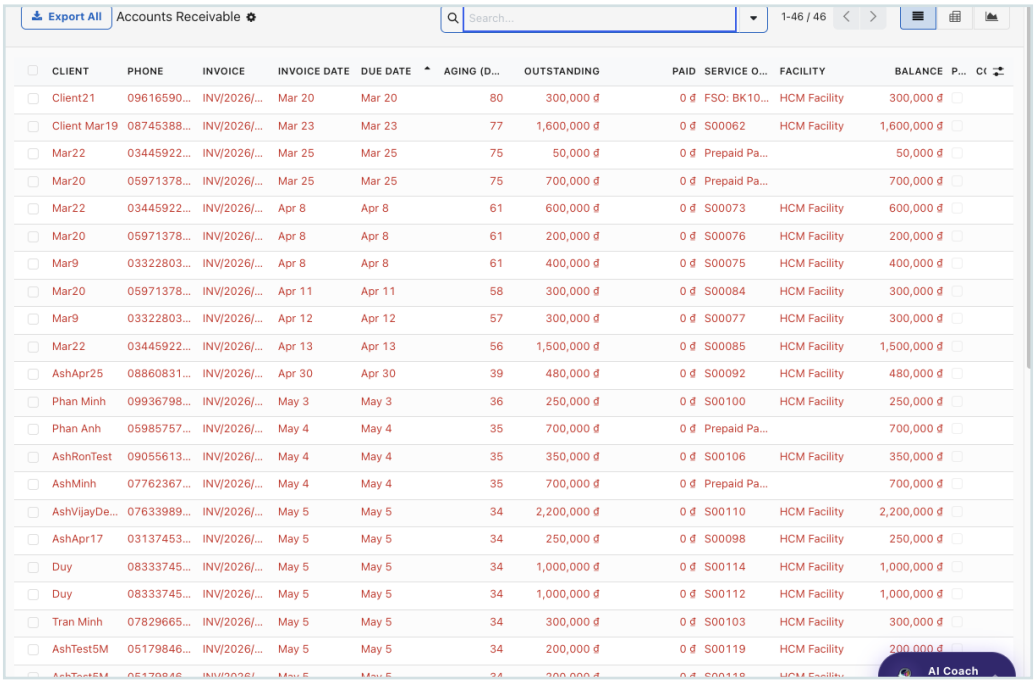
Tiền đang chuyển và Điều phối > Thu tiền hiển thị tiền nhân viên đã thu nhưng còn phải bàn giao về văn phòng. Đây là khái niệm khác với tiền khách hàng còn nợ.

1. Người thu ghi số tiền mặt thực tế vào đúng khách hàng hoặc hóa đơn bằng chức năng được phép.
2. Khi bàn giao, đối chiếu danh sách khoản tiền và mã với tiền thực nhận.
3. Chỉ ghi nhận bàn giao cho số đã xác minh. Điều tra chênh lệch thay vì tự sửa hóa đơn.
4. Mở lại khoản thu để xác nhận người giữ hoặc trạng thái bàn giao đã đổi. Kế toán hoàn tất đối chiếu còn lại.

Chờ bàn giao nghĩa là tiền ngoài hiện trường chưa hoàn tất việc giao về văn phòng. Đã giao và Đã đối chiếu là các bước sau khi hệ thống dùng những trạng thái đó. Nhận tiền nhân viên bàn giao không phải khách hàng thanh toán lần mới; ghi hai lần sẽ làm tăng sai số tiền nhận.

Cuối ca, kiểm tra khoản chưa bàn giao theo nhân viên và ngày, ghi người sẽ xử lý chênh lệch.

8.5 Công nợ, hoàn tiền, ghi có và gói dịch vụ



Hình 21. Công nợ: xem khách hàng và số còn phải thu.

Công nợ > Tổng quan công nợ tóm tắt tiền còn phải thu. Giao dịch công nợ hiển thị lịch sử chi tiết. Khách hàng quá hạn tập trung số chưa trả sau hạn. Lọc theo khách hàng và ngày, xem hóa đơn cùng phân bổ thanh toán, rồi tổ chức theo dõi phù hợp.

Chứng từ ghi có giảm hoặc điều chỉnh hóa đơn theo quy trình kế toán được duyệt. Hoàn tiền ghi số thực trả lại. Hai việc liên quan nhưng không phải cùng một sự kiện. Dùng Hoàn tiền / Ghi có với đúng hóa đơn gốc, lý do và số tiền; xác minh cả số dư điều chỉnh lẫn tiền thực chuyển.

Gói dịch vụ thể hiện quyền sử dụng dịch vụ trả trước. Trước khi bán hoặc áp dụng gói, kiểm tra khách hàng, dịch vụ bao gồm, hạn và phần còn lại. Gắn lần sử dụng với đúng buổi khám rồi kiểm tra số còn lại. Mua gói không đồng nghĩa đã hoàn tất mọi buổi khám trong gói. Không áp dụng gói không phù hợp chỉ vì còn giá trị.

Khi xuất tài chính, dùng chức năng được phép và kiểm tra kỳ, công ty, số hồ sơ cùng tổng. Tệp xuất cho MISA hoặc hệ thống khác không chứng minh nơi nhận đã nhập và đối chiếu thành công.

8.6 Nhật ký VAT, hóa đơn điện tử và hồ sơ BHYT

Nhật ký VAT và Nhật ký hóa đơn điện tử giúp theo dõi xử lý hóa đơn điện tử. Đọc mã nhà cung cấp, trạng thái yêu cầu và chi tiết lỗi. Hóa đơn nội bộ đã ghi sổ chưa chứng minh hóa đơn điện tử bên ngoài đã phát hành. Nếu yêu cầu thất bại, kiểm tra nguyên nhân và kết quả trước đó trước khi thử lại để tránh phát hành trùng.

Hồ sơ BHYT chuẩn bị yêu cầu có cấu trúc từ buổi khám đủ điều kiện đã hoàn tất và hóa đơn đã ghi sổ. Xem thông tin khách hàng/thẻ, liên kết hóa đơn, dữ liệu quyền lợi tại thời điểm lập, phần được chi trả từng dòng và phần khách hàng trả. Đánh dấu sẵn sàng chỉ ghi trạng thái trong phân hệ, không xác nhận cơ quan quốc gia đã nhận hoặc chấp thuận. Chức năng chuẩn bị hiện có không tự cung cấp quy trình XML/gửi lên cơ quan ở giai đoạn sau.

1. Mở đúng chứng từ nguồn, xác minh thông tin khách hàng.

2. Cùng nhân viên tài chính có quyền xem số tiền và lỗi kiểm tra.

3. Chỉ dùng quy trình hiện có được duyệt, kiểm tra trạng thái sau đó.

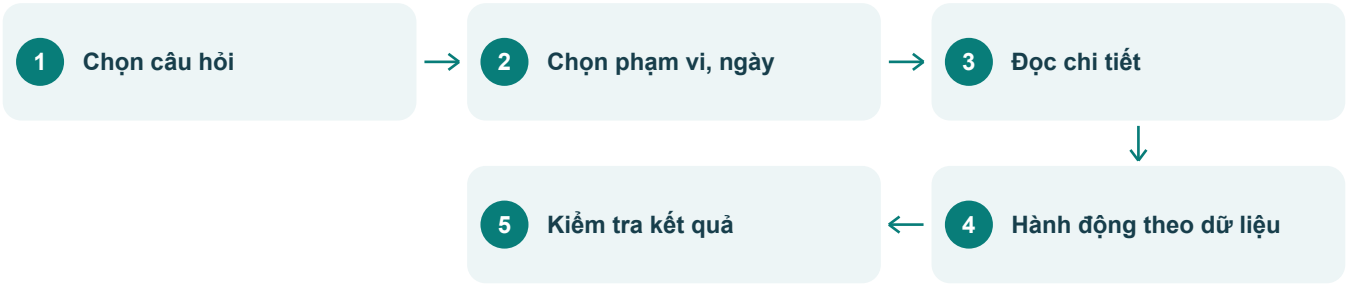
4. Phân biệt bằng chứng nhà cung cấp/tiếp nhận với trạng thái chuẩn bị nội bộ.

Hỏi người phụ trách tài chính hoặc tích hợp khi thiếu kết nối. Không sửa hồ sơ lâm sàng hoặc bịa mã nhà cung cấp để bỏ lỗi tài chính.

CHƯƠNG 09

Báo cáo, học tập và xử lý vấn đề hằng ngày

Quy trình thông thường



Trong chương này

Phân tích và báo cáo hữu ích

Học qua hướng dẫn, video và trợ lý

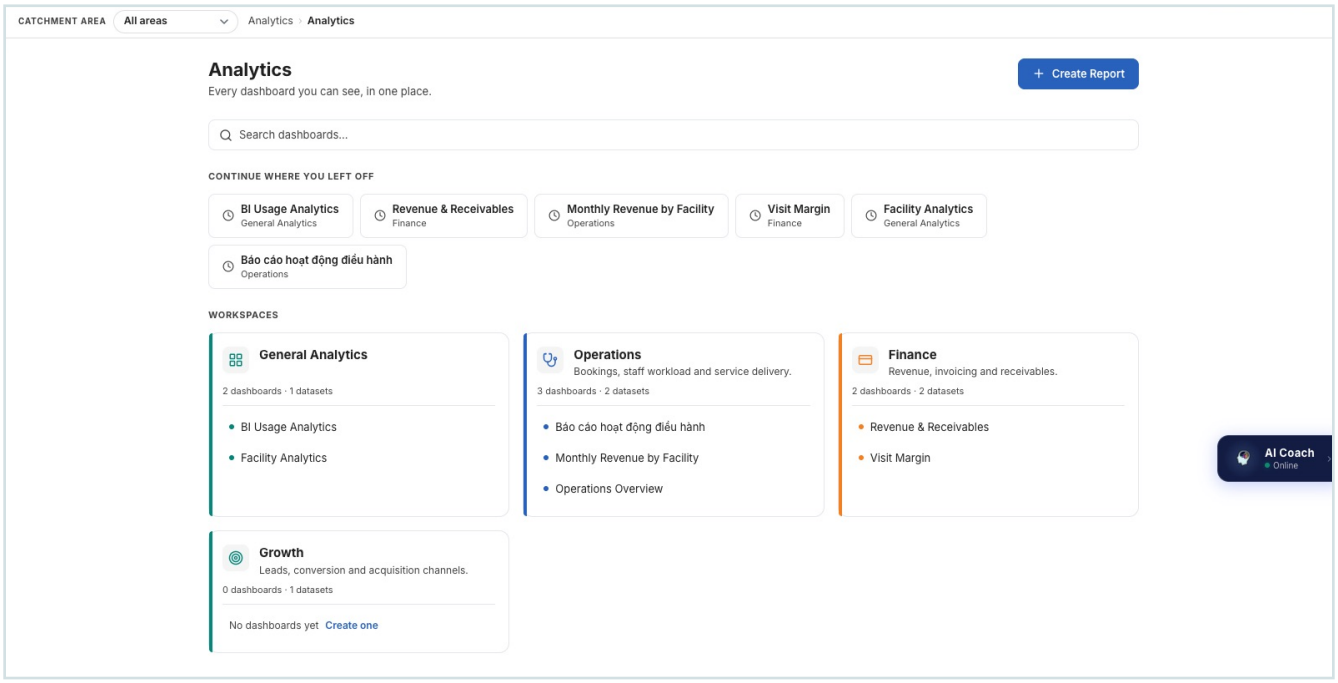
Lộ trình đào tạo và thực hành

Khi có việc không hoạt động

Từ điển dễ hiểu và danh sách kiểm tra mỗi ngày

Đọc quy trình từ bước 1. Vai trò, trạng thái hồ sơ và tính năng đã bật quyết định thao tác có sẵn. Kiểm tra kết quả đã lưu trước khi bàn giao cho người tiếp theo.

9.1 Phân tích và báo cáo hữu ích



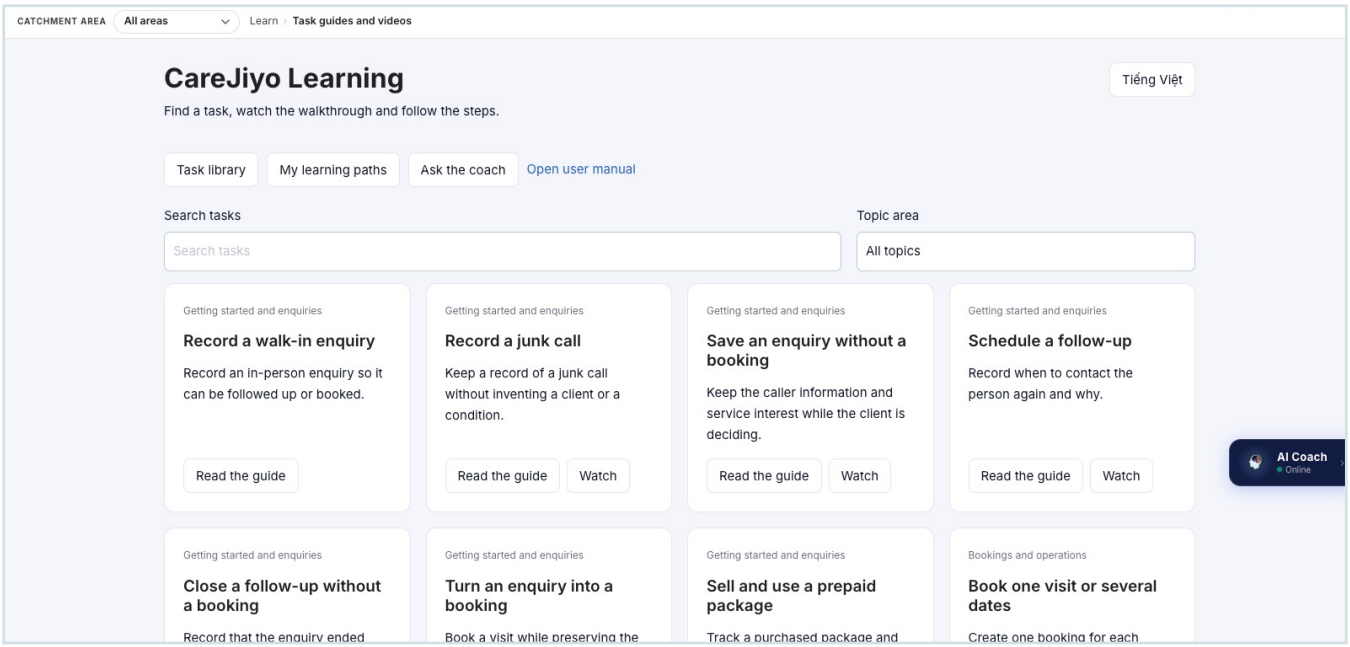
Hình 22. Trang Phân tích: chọn phân tích hoặc bảng phù hợp.

Phân tích cung cấp bảng điều khiển được phép và không gian Khám phá (Explore). Một bảng trả lời câu hỏi nghiệp vụ cụ thể; số liệu phụ thuộc ngày, công ty, khu vực và lần làm mới dữ liệu.

1. Mở Phân tích, chọn bảng liên quan công việc.
2. Đọc tiêu đề, chỉ tiêu và bộ lọc. Kiểm tra ngày đang nói đến ngày tạo yêu cầu, ngày khám dự kiến, ngày hóa đơn hay ngày thanh toán.
3. Dùng Khám phá để chọn dữ liệu, chỉ tiêu, cách nhóm hoặc bộ lọc được phép. So sánh một nhóm hồ sơ nhỏ đã biết trước khi tin vào phân tích mới.
4. Đối chiếu tổng với danh sách gốc khi có chức năng xem chi tiết. Biểu đồ là tổng hợp, chưa chắc dùng cùng định nghĩa với ô thống kê ở màn hình khác.
5. Chỉ xuất hoặc chia sẻ bằng điều khiển được phép, cho đúng đối tượng. Bảng theo lịch dùng thời gian và người nhận đã cấu hình.

Nếu dữ liệu có vẻ cũ, xem thông tin làm mới hoặc hỏi quản trị báo cáo. Không sửa lịch hẹn nguồn để làm biểu đồ khớp. Báo cáo hoặc bản xem trước nội bộ, kể cả báo cáo MOH hiện có, không chứng minh đã nộp hay được bên ngoài chấp thuận.

9.2 Học qua hướng dẫn, video và trợ lý



Hình 23. Thư viện học: tìm công việc, đọc bài hoặc xem video.

Mở Học tập > Hướng dẫn công việc và video. Tìm theo việc muốn làm, như theo dõi liên hệ, phân công, ghi chú lâm sàng hoặc thanh toán một phần. Dùng bộ lọc chủ đề để thu hẹp kết quả.

Đọc mục tiêu và Trước khi bắt đầu rồi làm theo các bước. Xem video mở phần hướng dẫn; các nút chương chuyển đến một hành động cụ thể. Chọn phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trình phát. Tiến độ đã đọc và đã xem thuộc tài khoản của bạn.

Lộ trình học nhóm công việc theo vai trò. Học lần lượt, làm câu hỏi kiểm tra và đọc phản hồi. Có thể sửa câu trả lời sai và thử lại. Ghi nhận hoàn tất là tiến độ học, không phải chứng chỉ chuyên môn hay quyền thực hiện hành động bị hạn chế.

Hỏi trợ lý dùng nội dung hướng dẫn đã công bố để tìm chỉ dẫn và liên kết đến bài hoặc đoạn video. Trợ lý không thực hiện công việc, không kiểm tra hoàn cảnh bệnh nhân hiện tại và không quyết định chuyên môn. Nếu không tìm được câu trả lời phù hợp, dùng tìm kiếm hoặc hỏi đồng nghiệp.

Care Coach > Hướng dẫn và video mở trợ giúp cạnh màn hình văn phòng. Trong ứng dụng di động, Hướng dẫn mở chỉ dẫn mà không rời công việc. Dùng khi chưa rõ nút hoặc bước tiếp theo.

9.3 Lộ trình đào tạo và thực hành

Học tập > Đào tạo cung cấp lộ trình đào tạo riêng khi phòng khám dùng bài học và trạm học. Làm theo chỉ dẫn, hoàn thành hoạt động được phép và xem phản hồi. Quản trị đào tạo quản lý bài công bố và theo dõi hồ sơ học hiện có.

Với bài thực hành, dùng hồ sơ và tài khoản được quản lý cho phép. Kiểm tra môi trường trước khi tạo lịch hẹn, thanh toán, tin nhắn hoặc hồ sơ lâm sàng. Thực hành trong hệ thống đang dùng vẫn có thể tạo dữ liệu thật hoặc gửi tin thật.

Lộ trình ngày đầu hữu ích: đăng nhập và tìm một hồ sơ; đọc liên hệ cùng lịch hẹn; xem quy trình của vai trò; xem một video phù hợp; làm một bài có người hướng dẫn; giải thích kết quả cho người đào tạo. Lặp lại đến khi nhận ra cả kết quả đúng lẫn ngoại lệ.

Nếu hướng dẫn khác màn hình, ghi tiêu đề màn hình, vai trò và tên nút rồi hỏi lại. Không tự dùng tài khoản quyền cao hơn để xử lý.

9.4 Khi có việc không hoạt động

Hiện tượng	Kiểm tra trước
Không tìm thấy hồ sơ	Nội dung tìm, trường ngày, khu vực, công ty và phân công.
Thiếu nút	Trạng thái hiện tại và vai trò; thao tác có thể chưa áp dụng.
Lỗi trường bắt buộc	Đọc thông báo, quay lại đúng trường và nhập thông tin chính xác.
Giá có vẻ sai	Dịch vụ, số lượng, ngày giờ, nơi, khu vực, thời lượng và chiết khấu được duyệt.
Không hoàn tất được buổi khám	Trạng thái bắt đầu, phân công, ghi chú và câu trả lời kết thúc.
Chưa thấy thanh toán	Đúng hóa đơn, khoản tiền đã lưu và phân bổ/đối chiếu.
Video không phát	Kết nối, tài khoản đăng nhập và vai trò; trước hết dùng bài viết.
Thiếu thông báo	Quyền thiết bị và danh sách công việc thật; nhờ Điều phối xác minh.
Hết thời gian chờ sau Lưu	Mở lại/tìm hồ sơ trước khi lặp thao tác.

Khi báo lỗi, cung cấp màn hình, mã hồ sơ, thời điểm, kết quả mong đợi và thông báo chính xác. Nêu những bước đã thử. Chỉ gửi thông tin cần thiết qua đường hỗ trợ có quyền. Ảnh chụp không nên chứa mật khẩu hoặc thông tin khách hàng không liên quan.

Không tạo hồ sơ lặp, đặt lại giá hoặc đổi quyền chỉ để làm mất lỗi. Giữ mã ban đầu để nhóm phụ trách truy tìm diễn biến.

9.5 Từ điển dễ hiểu và danh sách kiểm tra mỗi ngày

Thuật ngữ	Nghĩa dễ hiểu
Khu vực phụ trách	Địa bàn được giao cho phòng khám hoặc nhân viên.
Khách hàng tiềm năng	Yêu cầu có thể chuyển thành lịch hẹn.
Phân công	Liên kết giữa nhân viên và buổi khám.
Báo giá	Phí dịch vụ dự kiến.
Hóa đơn	Chứng từ tính tiền dịch vụ.
Công nợ phải thu / AR	Tiền phòng khám còn phải thu.
Đối chiếu	Khớp khoản thanh toán với đúng hồ sơ tài chính.
Đồng ý	Quyền được ghi nhận cho mục đích cụ thể.
eMAR	Hồ sơ điện tử ghi thực hiện thuốc.
EVV	Ghi nhận điện tử các sự kiện xác minh buổi khám.
Phần bổ sung	Nội dung sửa hoặc giải thích thêm gắn với hồ sơ cuối đã có.

Trước ca: kiểm tra danh tính, khu vực, ngày và hàng đợi được giao. Trong ca: xác nhận khách hàng, đọc chi tiết, thực hiện đúng quyền rồi kiểm tra kết quả đã lưu. Trước khi nghỉ: xem việc theo dõi, ghi chú, tiền và bàn giao chưa xong. Đăng xuất thiết bị dùng chung sau khi xác nhận đã lưu.

Khi chưa chắc, dừng ở bước chưa hiểu và dùng hướng dẫn liên quan hoặc hỏi đồng nghiệp phụ trách. Các bước nhỏ chính xác tốt hơn bấm nhanh nhiều lần mà không kiểm tra.